

外科学（一）题库 — batch017

依据：2023级外科学（一）复习重点（修订版）

总题量：300 题 | 题型：A1/A2/B1/X型

修复版本：Agent 4 (MedFix) 修复后

外科感染与无菌原则（30题）

1. [A1型] [记忆] 外科感染按病程分类，慢性感染的病程时限是：

- A. 超过1个月
- B. 超过2周
- C. 超过2个月
- D. 超过3周
- E. 超过3个月

答案：C

解析：根据教材P49，病程在3周之内为急性感染，超过2个月为慢性感染，介于两者之间为亚急性感染。

📖 教材P49

2. [A1型] [记忆] 下列哪种感染属于外科特异性感染？

- A. 皮肤疖
- B. 丹毒
- C. 气性坏疽
- D. 急性乳腺炎
- E. 急性阑尾炎

答案：C

解析：特异性感染由特定致病菌引起并具有独特临床表现，如结核、破伤风、气性坏疽、念珠菌病等。疖、痈、丹毒、急性乳腺炎、急性阑尾炎均属非特异性感染。

📖 教材P49

3. [A1型] [记忆] 浅表软组织感染最常见的致病菌是：

- A. 大肠埃希菌
- B. 铜绿假单胞菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 溶血性链球菌

- E. 变形杆菌

答案：C

解析：金黄色葡萄球菌是疖、痈、脓肿等浅表软组织感染的最常见致病菌。

📖 教材P49

4. [A1型] [记忆] 高压蒸汽灭菌后的物品使用期限一般为：

- A. 3天
- B. 7天
- C. 10天
- D. 14天
- E. 21天

答案：D

解析：高压蒸汽灭菌后无菌包在干燥、未打开的条件下保存有效期为14天。

📖 教材P49

5. [A1型] [理解] 破伤风梭菌产生的外毒素主要作用于：

- A. 神经肌肉接头
- B. 脊髓前角运动神经元
- C. 脊髓和脑干的突触
- D. 大脑皮质运动区
- E. 周围神经末梢

答案：C

解析：破伤风痉挛毒素吸收至脊髓、脑干等处，与联络神经细胞的突触相结合，抑制突触释放抑制性传递介质，使运动神经元失去中枢抑制而兴奋性增强。

📖 教材P59

6. [A1型] [记忆] 气性坏疽早期诊断的重要依据是：

- A. 血培养阳性
- B. 发热和白细胞升高
- C. 伤口局部表现
- D. 血清学检测
- E. 组织病理活检

答案：C

解析：教材P61明确指出：早期诊断的重要依据是局部表现。伤口内分泌物涂片检查有革兰氏阳性染色粗大杆菌和X线检查显示伤处软组织间积气有助于确诊。

📖 教材P61

7. [X型] [记忆] 气性坏疽的治疗措施包括：

- A. 彻底清创
- B. 大剂量青霉素
- C. 高压氧治疗
- D. 抗毒素血清
- E. 全身支持治疗

答案：ABCE

解析：气性坏疽治疗包括彻底清创、大剂量青霉素、高压氧治疗和全身支持治疗。抗毒素血清主要用于破伤风而非气性坏疽。

📖 教材P61

8. [X型] [理解] 破伤风的治疗原则包括：

- A. 中和游离毒素
- B. 镇静解痉控制抽搐
- C. 彻底清创去除毒素来源
- D. 应用广谱抗生素
- E. 防治并发症

答案：ABCDE

解析：破伤风综合治疗原则包括：TAT或人破伤风免疫球蛋白中和游离毒素、地西泮等镇静解痉、彻底清创去除坏死组织和毒素来源、青霉素或甲硝唑抗感染、以及呼吸道管理和营养支持等防治并发症措施。

📖 教材P59

9. [A1型] [记忆] 关于外科感染病原菌的叙述，下列哪项是不正确的？

- A. 疖的主要致病菌为金黄色葡萄球菌
- B. 丹毒主要由乙型溶血性链球菌引起
- C. 气性坏疽由产气荚膜杆菌引起
- D. 急性蜂窝织炎最常见致病菌为大肠埃希菌
- E. 破伤风由破伤风梭菌引起

答案：D

解析：急性蜂窝织炎最常见致病菌为溶血性链球菌和金黄色葡萄球菌，而非大肠埃希菌。大肠埃希菌主要引起腹腔感染和泌尿系感染。

📖 教材P49

10. [A2型] [应用] 男性，45岁，左小腿外伤后5天，伤口周围明显肿胀，触之有捻发音，伤口有恶臭分泌物。最可能的诊断是：

- A. 急性蜂窝织炎
- B. 气性坏疽
- C. 破伤风

- D. 坏死性筋膜炎
- E. 厌氧菌性肌炎

答案：B

解析：外伤后伤口出现捻发音（皮下气肿）、恶臭分泌物是气性坏疽的典型表现。产气荚膜杆菌分解组织中的糖类产生气体，形成特征性气肿。

📖 教材P61

11. [A1型] [理解] 破伤风痉挛毒素的作用机制是：

- A. 促进乙酰胆碱释放
- B. 抑制突触释放抑制性递质
- C. 直接破坏神经细胞膜
- D. 阻断神经肌肉接头传递
- E. 抑制乙酰胆碱酯酶活性

答案：B

解析：破伤风痉挛毒素与联络神经细胞的突触相结合，抑制突触释放抑制性传递介质（甘氨酸和GABA），运动神经元因失去中枢抑制而兴奋性增强，导致肌痉挛。

📖 教材P59

12. [A1型] [记忆] 灭菌法是指：

- A. 杀灭病原微生物的方法
- B. 杀灭所有微生物的方法
- C. 抑制微生物生长的方法
- D. 去除表面污物的方法
- E. 使用化学消毒剂的方法

答案：B

解析：灭菌法是指用物理或化学方法杀灭物体上所有微生物（包括芽胞）的方法。消毒则仅杀灭病原微生物，不要求杀灭所有微生物。

📖 教材P49

13. [X型] [理解] 关于浅部感染发生的诱因，正确的有：

- A. 皮肤完整性破坏
- B. 局部血液循环障碍
- C. 全身免疫功能低下
- D. 糖尿病等基础疾病
- E. 局部卫生条件差

答案：ABCDE

解析：浅部感染的诱因包括局部因素（皮肤屏障破坏、血运障碍、卫生条件差）和全身因

素（免疫功能低下、糖尿病、营养不良等），均可增加感染风险。

📖 教材P49

14. [A1型] [记忆] 真菌感染最常见的入侵途径是：

- A. 呼吸道
- B. 消化道
- C. 皮肤黏膜破损处
- D. 泌尿道
- E. 静脉导管

答案：C

解析：真菌感染最常见的入侵途径是皮肤黏膜破损处，尤其是在免疫功能低下患者中。念珠菌为最常见的机会性致病真菌。

📖 教材P49

15. [A2型] [应用] 男性，35岁，足底刺伤后6天，出现张口困难、苦笑面容、颈项强直。最可能的诊断是：

- A. 狂犬病
- B. 破伤风
- C. 脑膜炎
- D. 气性坏疽
- E. 化脓性肌炎

答案：B

解析：足底刺伤（深而窄的伤口，易形成厌氧环境）+潜伏期约6天+张口困难（咀嚼肌痉挛最早受累）+苦笑面容（面肌痉挛）+颈项强直，为破伤风的典型临床表现。

📖 教材P59

16. [A1型] [理解] 破伤风毒素还可引起交感神经过度兴奋，其临床表现不包括：

- A. 血压升高
- B. 心率增快
- C. 体温升高
- D. 自汗
- E. 皮肤苍白

答案：E

解析：根据RAG教材P59原文，破伤风毒素阻断脊髓对交感神经的抑制，引起血压升高、心率增快、体温升高、自汗等交感兴奋表现。皮肤苍白非典型表现。

📖 教材P59

17. [A1型] [记忆] 预防气性坏疽的关键措施是：

- A. 预防性使用抗生素
- B. 尽早彻底清创
- C. 注射抗毒素
- D. 高压氧预防
- E. 严格无菌操作

答案：B

解析：教材P61明确：预防的关键是尽早彻底清创，包括清除失活、缺血的组织，去除异物，对深而不规则的伤口要充分敞开引流，避免死腔存在。

 教材P61

18. [X型] [理解] 围手术期预防性使用抗菌药物的指征包括：

- A. 清洁-污染手术
- B. 污染手术
- C. 所有清洁手术
- D. 特殊情况的清洁手术
- E. 植入物手术

答案：ABDE

解析：教材P62指出：预防用药的指征主要是清洁-污染手术和污染手术，以及一些特殊情况下的清洁手术（如植入物手术、手术时间长、高危患者等）。并非所有清洁手术都需要预防用药。

 教材P62

19. [B1型] [理解] B1型题：将正确答案的字母填入题干后方。

共用选项：

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 乙型溶血性链球菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 破伤风梭菌

子题1：疖和痈最常见的致病菌是：

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 乙型溶血性链球菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 破伤风梭菌

答案：A

解析：疖和痈均为毛囊及其周围组织的化脓性感染，最常见致病菌是金黄色葡萄球菌。

20. [B1型] [理解] 子题2：丹毒最常见的致病菌是：

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 乙型溶血性链球菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 破伤风梭菌

答案：B

解析：丹毒是皮肤淋巴管网的非化脓性炎症，主要由乙型溶血性链球菌引起。

21. [B1型] [理解] 子题3：深部伤口厌氧感染出现肌肉痉挛的致病菌是：

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 乙型溶血性链球菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 破伤风梭菌

答案：E

解析：破伤风梭菌在深而窄的厌氧伤口中繁殖，产生痉挛毒素导致肌肉痉挛。

22. [B1型] [应用] 子题4：长期使用广谱抗生素后发生假膜性肠炎的主要致病菌是：

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 乙型溶血性链球菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 破伤风梭菌

答案：A

解析：长期使用广谱抗生素可致肠道菌群失调，耐药金黄色葡萄球菌过度生长引起假膜性肠炎。

23. [A1型] [记忆] 亚急性感染指的是病程在：

- A. 1周以内
- B. 1-2周
- C. 2-3个月

- D. 3周至2个月
- E. 3个月以上

答案：D

解析：根据教材P49，病程<3周为急性，3周至2个月为亚急性，>2个月为慢性。

📖 教材P49

24. [A2型] [应用] 男性，60岁，糖尿病史10年，右足底溃疡3周不愈，创面基底有白色膜状物覆盖。最可能的病原菌是：

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 念珠菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 厌氧链球菌

答案：C

解析：糖尿病患者免疫功能低下，慢性溃疡创面白色膜状物提示真菌（念珠菌）感染。真菌感染在免疫功能低下患者中常见，念珠菌为最常见的机会性致病真菌。

📖 教材P49

25. [X型] [理解] 真菌感染的临床表现可包括：

- A. 口腔黏膜白斑
- B. 消化道溃疡
- C. 全身性播散性感染
- D. 局部组织坏死
- E. 发热不退

答案：ABCDE

解析：真菌感染临床表现多样：口腔念珠菌病呈白斑样，消化道可形成溃疡，免疫功能极度低下者可发生全身播散性感染，侵入血管可致组织坏死，深部真菌感染常表现为抗生素治疗无效的持续发热。

📖 教材P49

26. [A1型] [分析] 破伤风患者突然发生窒息，最可能的原因是：

- A. 急性喉痉挛
- B. 呼吸道分泌物堵塞
- C. 呼吸肌持续痉挛
- D. 中枢性呼吸衰竭
- E. 急性肺水肿

答案：C

解析：破伤风痉挛毒素作用于脊髓和脑干，严重时引起呼吸肌（膈肌和肋间肌）持续痉挛，导致通气障碍和窒息，是破伤风患者的主要死因。喉痉挛多为声门局部痉挛，而呼吸肌痉挛累及全部呼吸肌群，是更常见且更危险的窒息原因。

教材P59

27. [A1型] [理解] 关于气性坏疽，下列哪项叙述是错误的？

- A. 致病菌为产气荚膜杆菌
- B. 伤口分泌物涂片可见G⁺粗大杆菌
- C. X线检查可显示软组织间积气
- D. 高压氧治疗为禁忌
- E. 预防关键是尽早彻底清创

答案：D

解析：高压氧治疗是气性坏疽的重要治疗措施之一，可抑制厌氧菌生长，绝非禁忌。其余选项均正确描述了气性坏疽的特征。

教材P61

28. [A1型] [分析] 某矿区发生爆炸伤患者，伤后8小时入院，伤口深而污秽，对其预防破伤风和气性坏疽最关键的措施是：

- A. 立即注射TAT
- B. 立即静脉使用大剂量青霉素
- C. 尽早彻底清创并充分引流
- D. 立即高压氧治疗
- E. 注射破伤风类毒素

答案：C

解析：破伤风和气性坏疽均为厌氧菌感染，彻底清创去除坏死组织、异物，充分敞开引流消除厌氧环境是两者共同的、最关键预防措施。TAT和青霉素是辅助措施，高压氧用于气性坏疽治疗而非常规预防，类毒素用于主动免疫不能紧急预防。

教材P59/P61

29. [A1型] [理解] 深部组织感染的常见病原菌中，与医院感染密切相关的条件致病菌是：

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 乙型溶血性链球菌
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 肺炎链球菌
- E. 脑膜炎奈瑟菌

答案：C

解析：铜绿假单胞菌为条件致病菌，广泛存在于医院环境中，是医院感染的重要病原菌之一。常见于免疫力低下、长期住院、使用广谱抗生素的患者。

📖 教材P49

30. [X型] [理解] 高压蒸汽灭菌法灭菌后的物品在下列哪些条件下可以延长使用期限：

- A. 干燥保存
- B. 包装完整未打开
- C. 存放在无菌间
- D. 超过14天应重新灭菌
- E. 真空包装

答案：ABCD

解析：高压蒸汽灭菌后物品在干燥、包装完整、未打开条件下有效期为14天。超过14天必须重新灭菌。真空包装不属于常规灭菌保存方法。

📖 教材P49

创伤与烧伤（21题）

31. [A1型] [记忆] 创伤愈合的基本过程按正确顺序排列是：

- A. 增生期→炎症期→塑形期
- B. 炎症期→增生期→塑形期
- C. 塑形期→增生期→炎症期
- D. 炎症期→塑形期→增生期
- E. 增生期→塑形期→炎症期

答案：B

解析：创伤愈合基本过程为三个连续且重叠的阶段：炎症期（止血、炎症细胞浸润）→增生期（肉芽组织形成、上皮化）→塑形期（胶原重塑、瘢痕形成和成熟）。

📖 教材P132

32. [X型] [记忆] 影响伤口愈合的全身因素包括：

- A. 营养不良
- B. 糖尿病因素
- C. 长期使用糖皮质激素
- D. 维生素C缺乏
- E. 局部血供不足

答案：ABCD

解析：影响伤口愈合的全身因素包括营养不良（低蛋白血症）、糖尿病、使用糖皮质激素/免疫抑制剂、维生素C和锌缺乏等。局部血供不足属于局部因素而非全身因素。

 教材P132

33. [A1型] [记忆] 创伤后最常见的严重并发症是：

- A. 严重感染
- B. 失血性休克
- C. 脂肪栓塞综合征
- D. 急性肾衰竭
- E. 应激性溃疡

答案：B

解析：严重创伤后休克是最常见且最早出现的严重并发症，主要由失血和血浆丢失导致有效循环血量减少引起，可迅速进展为多器官功能障碍。

 教材P132

34. [A2型] [应用] 男性，28岁，车祸致多发伤入院。查体：BP 80/50mmHg，HR 120次/分，R 28次/分。按多发伤救治原则，首先应采取的措施是：

- A. 全身CT检查明确损伤
- B. 立即手术止血
- C. 保持气道通畅并快速补液
- D. 包扎固定骨折
- E. 留置导尿管监测尿量

答案：C

解析：多发伤救治遵循ABC原则：A（气道）→B（呼吸）→C（循环）。患者休克状态（BP 80/50mmHg），首要是确保气道通畅和呼吸支持，同时快速建立静脉通路补液抗休克。先救命后治伤。

 教材P132

35. [A1型] [记忆] 按中国新九分法，成年男性双下肢（含臀部）烧伤面积占体表总面积的：

- A. 27%
- B. 36%
- C. 41%
- D. 46%
- E. 50%

答案：D

解析：按中国新九分法：双臀5%（女性6%），双足7%（女性6%），双小腿13%，双大腿21%，双下肢合计46%。

教材P138

36. [A1型] [记忆] 小儿头颈部面积占体表总面积的比例为：

- A. 头颈部9%
- B. $9+(12-\text{年龄})\%$
- C. 双下肢12%
- D. $12+(9-\text{年龄})\%$
- E. 躯干18%

答案：B

解析：小儿头颈部面积= $9+(12-\text{年龄})\%$ ，双下肢面积= $46-(12-\text{年龄})\%$ 。这是因为小儿头部比例较大，下肢比例较小，随年龄增长逐渐接近成人。

教材P138

37. [A1型] [记忆] 浅Ⅱ度烧伤的临床特点是：

- A. 仅伤及表皮层，局部红斑
- B. 伤及真皮浅层，大水疱形成
- C. 伤及真皮深层，痛觉迟钝
- D. 伤及皮肤全层，形成焦痂
- E. 伤及皮下组织，需植皮

答案：B

解析：浅Ⅱ度烧伤伤及真皮浅层（生发层健在），特征为大水疱形成、创面红润潮湿、剧痛。A为Ⅰ度，C为深Ⅱ度（痛觉迟钝），D为Ⅲ度。

教材P138

38. [A1型] [理解] Ⅲ度烧伤创面的处理原则是：

- A. 暴露疗法待其自愈
- B. 早期切痂植皮
- C. 抗生素软膏包扎
- D. 湿润烧伤膏换药
- E. 单纯清创后包扎

答案：B

解析：Ⅲ度烧伤伤及皮肤全层，无上皮再生能力，不能自愈，需早期切（削）痂+植皮封闭创面，以减少感染风险和瘢痕形成。

教材P138

39. [X型] [理解] 创伤并发症包括：

- A. 创面感染
- B. 低血容量性休克
- C. 脂肪栓塞综合征
- D. 急性肾功能衰竭
- E. 多器官功能障碍综合征

答案：ABCDE

解析：严重创伤的并发症包括感染（创面感染、破伤风、气性坏疽）、休克（失血性或创伤性）、脂肪栓塞综合征（长骨骨折后）、急性肾功能衰竭（挤压综合征）和MODS，均可危及生命。

📖 教材P132

40. [A1型] [理解] 影响伤口愈合的局部因素中，最为重要的是：

- A. 伤口局部疼痛
- B. 伤口异物存留
- C. 伤口感染和血供不足
- D. 伤口包扎方式
- E. 缝合材料选择

答案：C

解析：伤口感染和局部血供不足是影响伤口愈合最重要的局部因素。感染增加组织破坏和炎症反应，血供不足导致氧和营养物质缺乏，二者直接抑制肉芽组织形成和上皮化。

📖 教材P132

41. [A2型] [应用] 女性，5岁，热水烫伤躯干前侧及双上肢。按中国新九分法估算烧伤面积为：

- A. 27%
- B. 31%
- C. 36%
- D. 40%
- E. 45%

答案：C

解析：躯干前侧13%+双上肢18%(9×2)=31%。5岁小儿需按小儿公式校正（头颈大、下肢小），但躯干和上肢面积与成人相同，故仍为31%。注：若问及头颈或下肢则需用小儿公式。

📖 教材P138

42. [A1型] [记忆] 深Ⅱ度烧伤的愈合主要依靠：

- A. 表皮生发层再生
- B. 残存的皮肤附件上皮再生

- C. 创缘表皮爬行
- D. 自体植皮修复术
- E. 肉芽组织填充

答案：B

解析：深Ⅱ度烧伤伤及真皮深层，表皮生发层已被破坏，但残存的毛囊、汗腺、皮脂腺等皮肤附件上皮可再生修复创面。如无感染一般3-4周愈合。

 教材P138

43. [X型] [理解] 烧伤创面处理的基本原则包括：

- A. 清创去除坏死组织
- B. 防治创面感染
- C. 及时覆盖封闭创面
- D. 减轻疼痛
- E. 促进创面愈合

答案：ABCDE

解析：烧伤创面处理原则包括清创去除坏死组织和水疱、防治创面感染（外用抗生素或抗菌敷料）、及时覆盖封闭创面（敷料或植皮）、减轻疼痛和促进创面愈合。

 教材P138

44. [A2型] [应用] 男性，40岁，烧伤后3天，创面可见大量黄绿色脓性分泌物，伴有甜腥味。最可能的致病菌是：

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 乙型溶血性链球菌
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 大肠埃希菌
- E. 变形杆菌

答案：C

解析：铜绿假单胞菌感染的脓液呈黄绿色，具有特征性甜腥气味，是烧伤创面感染的常见致病菌，需警惕创面脓毒症。

 教材P138

45. [A1型] [记忆] I度烧伤的临床特点是：

- A. 红斑、剧痛、不留瘢痕
- B. 水疱、剧痛、不留瘢痕
- C. 痛觉迟钝、愈合后有瘢痕
- D. 焦痂形成、无痛
- E. 水疱、无痛、留瘢痕

答案：A

解析：Ⅰ度烧伤仅伤及表皮层，表现为局部红斑、轻度肿胀、烧灼样剧痛，3-7天愈合，不留瘢痕。

教材P138

46. [A1型] [理解] 关于多发伤临床特点，下列哪项叙述是错误的？

- A. 伤情复杂，多部位损伤
- B. 休克发生率高
- C. 应优先处理最明显的损伤
- D. 易发生漏诊和误诊
- E. 并发症多，死亡率高

答案：C

解析：多发伤救治应先处理威胁生命的损伤（如气道梗阻、张力性气胸、大出血等），而非优先处理最明显的损伤（如开放性骨折）。遵循「先救命后治伤」原则。

教材P132

47. [B1型] [理解] B1型题：以下不同深度烧伤的愈合特点。

共用选项：

- A. 3-7天愈合，无瘢痕
- B. 1-2周愈合，无瘢痕
- C. 3-4周愈合，有瘢痕
- D. 不能自愈，需植皮
- E. 2-3天愈合，有色素沉着

子题1：浅Ⅱ度烧伤的愈合特点是：

- A. 3-7天愈合，无瘢痕
- B. 1-2周愈合，无瘢痕
- C. 3-4周愈合，有瘢痕
- D. 不能自愈，需植皮
- E. 2-3天愈合，有色素沉着

答案：B

解析：浅Ⅱ度烧伤伤及真皮浅层，创面红润、水疱大、剧痛，无感染时1-2周愈合，不留瘢痕。

教材P138

48. [B1型] [理解] 子题2：深Ⅱ度烧伤的愈合特点是：

- A. 3-7天愈合，无瘢痕
- B. 1-2周愈合，无瘢痕
- C. 3-4周愈合，有瘢痕
- D. 不能自愈，需植皮

- E. 2-3天愈合，有色素沉着

答案：C

解析：深Ⅱ度烧伤伤及真皮深层，依靠残存皮肤附件上皮再生，无感染时3-4周愈合，留有瘢痕。

 教材P138

49. [B1型] [理解] 子题3：Ⅲ度烧伤的愈合特点是：

- A. 3-7天愈合，无瘢痕
- B. 1-2周愈合，无瘢痕
- C. 3-4周愈合，有瘢痕
- D. 不能自愈，需植皮
- E. 2-3天愈合，有色素沉着

答案：D

解析：Ⅲ度烧伤伤及皮肤全层甚至皮下组织，皮肤附件全部破坏，无上皮再生来源，不能自愈，必须早期切痂植皮。

 教材P138

50. [X型] [应用] 关于多发伤的救治原则，正确的有：

- A. 首先评估气道和呼吸
- B. 快速建立静脉通道补液
- C. 全面检查后一次性手术处理损伤
- D. 边抢救边诊断
- E. 优先处理威胁生命的损伤

答案：ABDE

解析：多发伤救治原则为边抢救边诊断，优先处理威胁生命的损伤（ABC），不要求全面检查后一次性手术。分期手术（损伤控制外科）比一次性全面手术更安全。

 教材P132

51. [A1型] [应用] 大面积烧伤患者伤后48小时内最可能出现的电解质紊乱是：

- A. 高钠血症
- B. 低钠血症
- C. 高钾血症
- D. 低钾血症
- E. 高钙血症

答案：C

解析：大面积烧伤后大量组织细胞破坏，细胞内钾释放入血；同时由于休克期肾功能减

退，钾排出减少，早期可出现高钾血症。进入多尿期后则可转为低钾血症。

教材P138

休克（37题）

52. [A1型] [记忆] 休克的定义是：

- A. 血压低于90/60mmHg的状态
- B. 有效循环血量锐减致组织灌注不足
- C. 心输出量下降导致的临床状态
- D. 血容量显著不足导致的血流动力学紊乱
- E. 外周血管扩张导致的低血压状态

答案：B

解析：休克是有效循环血量急剧减少、组织灌注不足，导致细胞代谢紊乱和器官功能障碍的临床综合征。核心是组织灌注不足，而非单纯的低血压。

教材P18

53. [A1型] [理解] 休克代偿期（早期）血压的变化特点是：

- A. 血压明显下降
- B. 血压可正常或略升高
- C. 血压先升后降
- D. 收缩压下降而舒张压正常
- E. 血压不变但脉压增宽

答案：B

解析：休克代偿期机体通过交感-肾上腺髓质系统兴奋，儿茶酚胺大量释放，使心率加快、外周血管收缩，血压可维持正常甚至略升高，但脉压减小。此期血压正常不能排除休克。

教材P18

54. [X型] [记忆] 休克的一般监测指标包括：

- A. 神志状态
- B. 皮肤色泽温度
- C. 血压和脉搏
- D. 每小时尿量
- E. 中心静脉压

答案：ABCD

解析：一般监测包括神志（反映脑灌注）、皮肤色泽温度（反映外周灌注）、血压脉搏、尿量（反映肾灌注）。中心静脉压属于特殊监测指标。

教材P18

55. [A1型] [记忆] 休克时脉搏的典型特点是：

- A. 脉率减慢、脉弱
- B. 脉率加快、脉细弱
- C. 脉率正常、脉压增大
- D. 脉率减慢、脉洪大
- E. 脉率加快、脉洪大

答案：B

解析：休克时由于交感神经兴奋和血容量不足，典型脉搏特点为脉率加快（代偿性心率↑）和脉搏细弱（每搏输出量↓），是早期识别休克的重要体征。

📖 教材P18

56. [X型] [记忆] 休克的特殊监测指标包括：

- A. 中心静脉压
- B. 肺动脉楔压
- C. 心输出量
- D. 混合静脉血氧饱和度
- E. 血乳酸水平

答案：ABCDE

解析：特殊监测包括：CVP（反映右心前负荷）、PAWP（反映左心前负荷）、CO（心输出量）、SvO₂（组织氧利用情况）、血乳酸（反映组织缺氧和灌注不足程度）。

📖 教材P18

57. [A1型] [理解] 休克早期出现少尿的主要机制是：

- A. 肾功能衰竭
- B. 肾血流减少和ADH分泌增加
- C. 膀胱功能障碍
- D. 下尿路梗阻
- E. 血容量过多

答案：B

解析：休克早期少尿机制：有效循环血量↓→肾血流量↓→肾小球滤过率↓；同时ADH和醛固酮分泌↑→水钠重吸收↑→尿量↓。此时肾功能尚未发生器质性损害，补液后尿量可恢复。

📖 教材P18

58. [A1型] [理解] 休克微循环改变的正确分期顺序是：

- A. 淤血期→缺血期→衰竭期
- B. 衰竭期→缺血期→淤血期
- C. 缺血期→淤血期→衰竭期

- D. 缺血期→衰竭期→淤血期
- E. 淤血期→衰竭期→缺血期

答案：C

解析：休克微循环改变分为三期：微循环缺血期（代偿期，儿茶酚胺↑→微动脉收缩）、微循环淤血期（失代偿期，酸中毒→前阻力↓后阻力↑→血液淤滞）、微循环衰竭期（DIC期，凝血功能障碍→组织坏死）。

📖 教材P18

59. [A1型] [记忆] 低血容量性休克时最早受损的器官是：

- A. 心脏
- B. 肺脏
- C. 肾脏
- D. 肝脏
- E. 脑

答案：C

解析：休克时血液重新分布以保证心脑血管供血，皮肤、骨骼肌和内脏血管床收缩明显。肾脏对缺血最敏感，是最早出现功能障碍的器官（表现为少尿）。

📖 教材P18

60. [A1型] [理解] 关于血管收缩剂在休克治疗中的应用，下列哪项是错误的？

- A. 可加重肾缺血
- B. 增加组织缺氧
- C. 应在充分补液基础上使用
- D. 各类低灌注均应首选血管收缩剂
- E. 可能增加心肌耗氧量

答案：D

解析：血管收缩剂并非所有类型休克的首选。应在充分补液后仍存在低血压时使用，且需根据血流动力学类型选择血管活性药物。过早或不当使用可加重肾缺血和组织缺氧。

📖 教材P18

61. [X型] [理解] 使用血管收缩剂可能出现的不良反应包括：

- A. 肾血管收缩加重肾缺血
- B. 外周组织灌注进一步减少
- C. 心肌耗氧量增加
- D. 心律失常
- E. 肠黏膜缺血

答案：ABCDE

解析：血管收缩剂（如去甲肾上腺素）通过激动 α 受体收缩血管，可导致肾血管收缩加重肾缺血、外周组织灌注减少、心肌耗氧量增加诱发心律失常、肠黏膜缺血破坏肠屏障功能。

📖 教材P18

62. [A1型] [记忆] 休克类型按病因分类不包括：

- A. 低血容量性休克
- B. 心源性休克
- C. 分布性休克
- D. 梗阻性休克
- E. 代谢性休克

答案：E

解析：休克按病因分为低血容量性、心源性、分布性（感染性/过敏性/神经源性）和梗阻性四类。「代谢性休克」不是标准分型。

📖 教材P18

63. [A1型] [理解] 感染性休克的冷休克（低排高阻型）血流动力学特征是：

- A. 心输出量增加、外周阻力降低
- B. 心输出量降低、外周阻力增加
- C. 心输出量正常、外周阻力正常
- D. 心输出量增加、外周阻力正常
- E. 心输出量正常、外周阻力降低

答案：B

解析：冷休克（低排高阻型）表现为心输出量降低、外周血管阻力增加，皮肤湿冷苍白，多见于G⁻杆菌感染，预后较差。暖休克则相反（高排低阻型）。

📖 教材P18

64. [A1型] [理解] 感染性休克的暖休克（高排低阻型）最常见的致病菌是：

- A. 大肠埃希菌
- B. 铜绿假单胞菌
- C. 金葡菌等G⁺球菌
- D. 厌氧菌混合感染
- E. 变形杆菌属

答案：C

解析：暖休克（高排低阻型）常见于G⁺球菌感染（如金黄色葡萄球菌），心输出量增加、外

周阻力下降，四肢温暖干燥，预后相对较好。G-杆菌感染则多表现为冷休克。

教材P18

65. [A2型] [应用] 男性，55岁，因车祸致脾破裂，BP 70/40mmHg，HR 130次/分，皮肤湿冷。此患者休克类型为：

- A. 心源性休克
- B. 感染性休克
- C. 低血容量性休克
- D. 神经源性休克
- E. 梗阻性休克

答案：C

解析：脾破裂导致腹腔内大量出血，有效循环血量急剧减少，表现为典型的低血容量性（失血性）休克：低血压、心动过速、皮肤湿冷。

教材P18

66. [X型] [记忆] 周围循环监测的指标包括：

- A. 毛细血管充盈时间
- B. 皮肤与肛门的温差
- C. 皮肤色泽
- D. 中心静脉压
- E. 每小时尿量

答案：ABC

解析：周围循环监测主要反映外周组织灌注状态，包括毛细血管充盈时间（正常<2秒）、皮肤与中心温度差（温差增大提示外周血管收缩）、皮肤色泽。CVP和尿量分别属于特殊监测和一般监测。

教材P18

67. [A1型] [理解] 血管活性药物选择的主要依据是：

- A. 休克病因
- B. 血流动力学类型
- C. 患者年龄
- D. 休克持续时间
- E. 基础疾病

答案：B

解析：血管活性药物的选择应根据休克的血流动力学类型（如前负荷、后负荷、心输出量等参数），而非简单依据休克病因或患者一般情况。

教材P18

68. [A1型] [理解] 创伤性休克的分类包括：

- A. 失血性和非失血性
- B. 原发性和继发性
- C. 急性和慢性
- D. 轻度和重度
- E. 代偿性和失代偿性

答案：A

解析：创伤性休克按有无大量失血分为失血性和非失血性（如大量血浆丢失、心脏压塞、张力性气胸等引起）。

📖 教材P18

69. [X型] [记忆] 失血性休克的主要治疗措施包括：

- A. 迅速控制出血
- B. 补充血容量
- C. 纠正酸碱失衡
- D. 血管活性药物
- E. 预防感染

答案：ABCD

解析：失血性休克的主要治疗：①控制出血（压迫、手术等）；②快速补充血容量（晶体液/胶体液/输血）；③纠正酸中毒（扩容后可自行纠正，严重时补碱）；④必要时使用血管活性药物。预防感染非主要治疗措施。

📖 教材P18

70. [A2型] [应用] 女性，50岁，因急性化脓性胆管炎入院，T 39.2℃，BP 75/50mmHg，HR 120次/分，四肢温暖。该患者感染性休克的血流动力学类型最可能为：

- A. 低排高阻型
- B. 高排低阻型
- C. 低排低阻型
- D. 高排高阻型
- E. 正常型

答案：B

解析：患者四肢温暖（暖休克特征）+感染来源（胆道感染，常见G⁻杆菌但早期可呈暖休克表现），提示高排低阻型。但需注意胆道感染G⁻杆菌也可早期一过性呈暖休克后转为冷休克。

📖 教材P18

71. [A1型] [分析] 休克患者补液后尿量仍<25ml/h，CVP正常，此时最合理的处理是：

- A. 继续加快补液
- B. 使用利尿剂增加尿量
- C. 使用血管收缩剂提升血压
- D. 进行补液试验
- E. 立即血液透析

答案：D

解析：CVP正常但尿量少时，不能确定是补液不足还是肾功能开始受损。应进行补液试验：在15-30分钟内快速输入250-500ml液体，观察CVP和尿量变化。如CVP升高而尿量不增加，提示肾功能受损可能；如尿量增加，则说明补液仍不足。

📖 教材P18

72. [A2型] [应用] 男性，30岁，烧伤面积60%（II-III度），伤后6小时，BP 85/55mmHg，HR 115次/分，尿量15ml/h。首要的处理是：

- A. 使用多巴胺升压
- B. 使用利尿剂增加尿量
- C. 加快晶体液和胶体液输注
- D. 使用碳酸氢钠纠正酸中毒
- E. 使用糖皮质激素

答案：C

解析：大面积烧伤后大量血浆样液体从创面丢失，导致低血容量性休克。BP低、HR快、尿量少均提示容量严重不足，首要处理是快速补液（晶体液和胶体液按补液公式计算），而非使用升压药。

📖 教材P18

73. [A1型] [分析] 以下哪项最能提示休克由微循环缺血期进入微循环淤血期？

- A. 血压下降至90/60mmHg以下
- B. 皮肤由苍白转为花斑发绀
- C. 心率增快超过120次/分
- D. 尿量减少至20ml/h
- E. 神志由烦躁转为淡漠

答案：B

解析：微循环缺血期皮肤血管收缩呈苍白，进入淤血期后大量血液淤滞在毛细血管床，组织缺氧加重，皮肤由苍白转为花斑、发绀。这是判断休克进展的重要临床体征，反映了微循环从代偿走向失代偿。

📖 教材P18

74. [A1型] [记忆] 休克临床表现中，下列哪项不属休克的典型表现：

- A. 神志淡漠或烦躁
- B. 皮肤湿冷苍白
- C. 脉搏细速
- D. 体温持续高热
- E. 尿量减少

答案：D

解析：高热并非休克本身的典型表现（感染性休克可有发热，但这是由于感染而非休克本身）。休克的核心表现：神志改变（脑灌注↓）、皮肤湿冷（外周血管收缩）、脉搏细速、尿量减少（肾灌注↓）。

📖 教材P18

75. [A2型] [应用] 男性，65岁，急性广泛前壁心肌梗死后出现BP 72/48mmHg，HR 105次/分，双肺底可闻及湿啰音，颈静脉充盈。此休克类型为：

- A. 低血容量性休克
- B. 心源性休克
- C. 感染性休克
- D. 梗阻性休克
- E. 神经源性休克

答案：B

解析：广泛前壁心梗→心肌收缩力急剧下降→心输出量降低→心源性休克。双肺底湿啰音提示肺淤血（左心衰），颈静脉充盈提示右心衰，均为心源性休克的特征表现。

📖 教材P18

76. [A1型] [理解] 关于休克时微循环改变，下列哪项叙述是错误的？

- A. 缺血期微动脉和毛细血管前括约肌收缩
- B. 淤血期毛细血管后阻力大于前阻力
- C. 衰竭期可发生弥散性血管内凝血
- D. 缺血期毛细血管床灌注减少
- E. 淤血期毛细血管静水压降低

答案：E

解析：淤血期毛细血管前阻力降低而毛细血管后阻力仍高，血液淤滞在毛细血管床，毛细血管静水压升高（而非降低），液体外渗加重有效循环血量减少。

📖 教材P18

77. [X型] [理解] 感染性休克可能继发的疾病包括：

- A. 急性呼吸窘迫综合征
- B. 急性肾功能衰竭

- C. 弥散性血管内凝血
- D. 多器官功能障碍综合征
- E. 应激性溃疡

答案：ABCDE

解析：感染性休克可引发全身炎症反应，序贯性累及各器官：肺→ARDS，肾→急性肾衰竭，凝血系统→DIC，多器官→MODS，胃肠道→应激性溃疡和肠屏障功能衰竭。

教材P18

78. [A1型] [分析] 感染性休克患者在充分补液和使用去甲肾上腺素后仍持续低血压，加用多巴酚丁胺的主要目的是：

- A. 增加外周血管阻力
- B. 增加心肌收缩力
- C. 扩张肾血管
- D. 降低肺动脉压
- E. 抑制炎症反应

答案：B

解析：多巴酚丁胺为 β_1 受体激动剂，主要作用是增加心肌收缩力和心输出量，对心功能受损的休克患者可改善心脏泵功能。去甲肾上腺素已提供足够的血管收缩，此时加用正性肌力药物针对的是心功能不全这一环节。

教材P18

79. [B1型] [理解] B1型题：休克血流动力学类型鉴别。

共用选项：

- A. CVP↓ BP↓ CO↓ SVR↑
- B. CVP↑ BP↓ CO↓ SVR↑
- C. CVP↓ BP↓ CO↑ SVR↓
- D. CVP↑ BP↓ CO↓ SVR—
- E. CVP— BP↓ CO↑ SVR↓

子题1：低血容量性休克的血流动力学特征为：

- A. CVP↓ BP↓ CO↓ SVR↑
- B. CVP↑ BP↓ CO↓ SVR↑
- C. CVP↓ BP↓ CO↑ SVR↓
- D. CVP↑ BP↓ CO↓ SVR—
- E. CVP— BP↓ CO↑ SVR↓

答案：A

解析：低血容量性休克：血容量不足→前负荷↓→CVP↓→心输出量↓→血压↓→代偿性外周血管收缩→SVR↑。

教材P18

80. [B1型] [理解] 子题2：心源性休克的血流动力学特征为：

- A. CVP↓ BP↓ CO↓ SVR↑
- B. CVP↑ BP↓ CO↓ SVR↑
- C. CVP↓ BP↓ CO↑ SVR↓
- D. CVP↑ BP↓ CO↓ SVR—
- E. CVP— BP↓ CO↑ SVR↓

答案：B

解析：心源性休克：心肌泵功能衰竭→心输出量↓→血压↓+心室残余血量↑→CVP↑（右心衰时）+代偿性外周血管收缩→SVR↑。

📖 教材P18

81. [B1型] [理解] 子题3：暖休克（高排低阻型）的血流动力学特征为：

- A. CVP↓ BP↓ CO↓ SVR↑
- B. CVP↑ BP↓ CO↓ SVR↑
- C. CVP↓ BP↓ CO↑ SVR↓
- D. CVP↑ BP↓ CO↓ SVR—
- E. CVP— BP↓ CO↑ SVR↓

答案：E

解析：暖休克（高排低阻型）：炎症介质→外周血管广泛扩张→SVR↓→血压↓；心肌代偿→心输出量↑；CVP可正常或降低。

📖 教材P18

82. [B1型] [应用] 子题4：心包填塞所致休克的血流动力学特征为：

- A. CVP↓ BP↓ CO↓ SVR↑
- B. CVP↑ BP↓ CO↓ SVR↑
- C. CVP↓ BP↓ CO↑ SVR↓
- D. CVP↑ BP↓ CO↓ SVR—
- E. CVP— BP↓ CO↑ SVR↓

答案：B

解析：心包填塞（梗阻性休克）：心脏受压→舒张受限→心室充盈障碍→心输出量↓→血压↓+CVP↑（回心血流受阻）+代偿性SVR↑。特征为Beck三联征（低血压+颈静脉怒张+心音遥远）。

📖 教材P18

83. [A1型] [记忆] 休克指数（SI=HR/SBP）的正常值为：

- A. 0.2-0.4
- B. 0.5-0.7

- C. 0.8-1.0
- D. 1.0-1.5
- E. 1.5-2.0

答案：B

解析：休克指数=心率/收缩压，正常值约为0.5-0.7。SI=1.0时提示血容量丢失约20-30%，SI>1.0提示丢失约30-50%。

 教材P18

84. [A2型] [应用] 患者HR 120次/分，SBP 80mmHg，休克指数为1.5。该值提示血容量丢失约为：

- A. 10%以下
- B. 10%-20%
- C. 20%-30%
- D. 30%-50%
- E. 50%以上

答案：D

解析：SI=120/80=1.5，>1.0，提示血容量丢失约30%-50%，属于重度失血性休克，需紧急输血和手术止血。

 教材P18

85. [X型] [应用] 休克患者出现以下哪些表现提示进入不可逆期：

- A. 对血管活性药物反应丧失
- B. 顽固性代谢性酸中毒
- C. DIC表现
- D. 持续性无尿
- E. 神志模糊

答案：ABCD

解析：休克进入不可逆期（微循环衰竭期）的标志：血管对升压药反应丧失（血管平滑肌麻痹）、顽固性酸中毒、DIC（消耗性凝血病+纤溶亢进）、持续无尿（肾小管坏死）。神志模糊可见于休克各期，非不可逆期特有。

 教材P18

86. [A1型] [理解] CVP降低、BP降低提示：

- A. 血容量不足
- B. 心功能不全
- C. 容量血管过度收缩
- D. 外周血管阻力过高
- E. 肺循环阻力升高

答案：A

解析：CVP降低反映回心血量不足（前负荷不足），BP降低反映心输出量不足以维持正常血压，二者同时降低最常见于血容量不足（低血容量性休克）。CVP↑+BP↓则提示心功能不全。

📖 教材P18

87. [A1型] [理解] 中心静脉压（CVP）的正常值为：

- A. 0-3cmH₂O
- B. 0-5mmHg
- C. 5-12cmH₂O
- D. 12-18cmH₂O
- E. 18-25cmH₂O

答案：C

解析：成人CVP正常值为5-12cmH₂O（或4-10mmHg）。CVP<5cmH₂O提示血容量不足，CVP>15cmH₂O提示心功能不全或容量过多。

📖 教材P18

88. [A1型] [记忆] 血乳酸正常值为：

- A. 0.1-0.5mmol/L
- B. 0.5-1.5mmol/L
- C. 1.5-3.0mmol/L
- D. 3.0-5.0mmol/L
- E. >5.0mmol/L

答案：B

解析：血乳酸正常值为0.5-1.5mmol/L。>2mmol/L提示组织缺氧，>4mmol/L提示严重缺氧和预后不良，是评估休克严重程度和复苏效果的重要指标。

📖 教材P18

SIRS/MODS（8题）

89. [A1型] [记忆] SIRS（全身炎症反应综合征）的诊断标准中，体温的条件是：

- A. >37.5°C或<36°C
- B. >38°C或<36°C
- C. >38°C或<36.5°C
- D. >38.5°C或<35°C
- E. >39°C或<35°C

答案：B

解析：SIRS诊断标准：体温 $>38^{\circ}\text{C}$ 或 $<36^{\circ}\text{C}$ ；心率 >90 次/分；呼吸 >20 次/分或 $\text{PaCO}_2 < 32\text{mmHg}$ ； $\text{WBC} > 12 \times 10^9/\text{L}$ 或 $< 4 \times 10^9/\text{L}$ 或幼稚细胞 $>10\%$ 。满足2项及以上即可诊断。

教材P25

90. [X型] [记忆] SIRS的诊断标准包括：

- A. 血糖 $>11.1\text{mmol/L}$
- B. 白细胞 >12 或 $<4 \times 10^9/\text{L}$
- C. 呼吸 >20 次/分或 PaCO_2 低
- D. 体温 $>38^{\circ}\text{C}$ 或 $<36^{\circ}\text{C}$
- E. 心率 >90 次/分

答案：DECB

解析：SIRS诊断标准为上述四项（ABCD），满足 ≥ 2 项即可诊断。血糖 $>11.1\text{mmol/L}$ 为应激性高血糖或糖尿病的标准，不是SIRS的诊断条件。

教材P25

91. [A1型] [理解] MODS（多器官功能障碍综合征）的诊断要点是：

- A. 同时出现2个以上器官功能障碍
- B. 序贯性器官功能障碍，且患者无基础器官疾病
- C. 任何原因导致的单一器官衰竭
- D. 慢性疾病终末期的多器官衰竭
- E. 手术后即刻出现的器官功能异常

答案：B

解析：MODS核心特征：①序贯性（一个器官接着一个器官发生障碍，而非同时）；②发生在严重创伤、感染、休克等急性打击后；③患者原无器官功能障碍的基础疾病。与慢性疾病终末期的多器官衰竭有本质区别。

教材P25

92. [X型] [记忆] MODS的常见诱发因素包括：

- A. 严重感染
- B. 休克
- C. 严重创伤
- D. 重症胰腺炎
- E. 大手术

答案：ABCDE

解析：MODS的常见诱发因素包括严重感染（最常见）、各种原因引起的休克、严重创伤或

大手术、重症急性胰腺炎、大面积烧伤等。这些因素通过触发SIRS启动序贯性器官损伤。

教材P25

93. [A1型] [理解] MODS中最常首先受累的器官是：

- A. 心脏
- B. 肺脏
- C. 肝脏
- D. 肾脏
- E. 胃肠道

答案：B

解析：MODS中肺脏通常最先受累，表现为ARDS。因为肺脏接受全部心输出量，且肺泡-毛细血管网面积大，炎症介质和中性粒细胞易在肺内大量聚集活化。

教材P25

94. [A1型] [理解] 肠功能衰竭在MODS中的关键病理意义是：

- A. 引起营养不良
- B. 肠屏障破坏致菌群毒素移位
- C. 引起电解质紊乱
- D. 消化道出血
- E. 肠麻痹和肠胀气

答案：B

解析：肠道是MODS的「启动器」：肠缺血→肠黏膜屏障破坏→肠道内细菌和毒素（内毒素）通过受损的肠黏膜进入门静脉系统和淋巴系统→激活全身炎症反应→加剧远隔器官损伤。这被称为「肠源性感染」或「细菌移位」。

教材P25

95. [A2型] [应用] 男性，50岁，重症急性胰腺炎入院第5天。T 38.5℃，HR 105次/分，R 30次/分，PaO₂ 55mmHg，WBC 16×10⁹/L，尿量 300ml/d，Cr 280μmol/L。该患者目前状态属于：

- A. SIRS
- B. 严重脓毒症
- C. MODS
- D. 胰腺局部并发症
- E. 单纯急性肾衰竭

答案：C

解析：患者满足SIRS诊断标准（T>38℃、HR>90、R>20、WBC>12×10⁹/L，四项均符合），同时出现呼吸功能障碍（PaO₂ 55mmHg提示ARDS）和肾功能障碍（少尿+Cr升

高)，为序贯性器官功能障碍，符合MODS诊断。

教材P25

96. [X型] [应用] 关于肠功能衰竭的防治措施，正确的有：

- A. 早期肠内营养保护肠黏膜
- B. 使用谷氨酰胺维持肠上皮完整性
- C. 使用抗生素清除肠道菌群
- D. 维持肠系膜血流灌注
- E. 使用益生菌维护肠道微生态

答案：ABDE

解析：肠功能衰竭防治措施包括早期肠内营养（维持肠黏膜营养和屏障功能）、谷氨酰胺（肠上皮细胞的重要能量来源和氮源）、维持肠道血流灌注、益生菌调节肠道菌群。抗生素不能常规用于清除肠道菌群（可能导致菌群失调和耐药），仅在明确肠道感染指征时使用。

教材P25

水电解质与酸碱平衡（12题）

97. [A1型] [记忆] 高渗性缺水最常见的病因是：

- A. 剧烈大量呕吐
- B. 严重大量腹泻
- C. 水摄入不足或大量出汗
- D. 大面积烧伤
- E. 肠梗阻体液丢失

答案：C

解析：高渗性缺水（血钠 $>150\text{mmol/L}$ ）主要因水丢失多于钠引起。常见病因：水摄入不足（昏迷、食管疾病）、水丢失过多（大量出汗、高渗性利尿如使用甘露醇、尿崩症）。呕吐和腹泻通常导致等渗或低渗性缺水。

教材P12

98. [A1型] [记忆] 低渗性缺水最常见的原因是：

- A. 大量出汗后只补水
- B. 大量饮水
- C. 使用利尿剂
- D. 高血糖渗透性利尿
- E. 限制钠盐摄入

答案：A

解析：低渗性缺水最常见的原因因为消化液持续丢失（呕吐、腹泻、胃肠减压、肠痿等）后只补充水或葡萄糖液，未补充电解质，导致钠丢失多于水丢失。大量出汗后只补水也可引起。

📖 教材P12

99. [A1型] [记忆] 静脉补钾的首要条件是：

- A. 血钾 $<3.5\text{mmol/L}$
- B. 尿量 $>40\text{ml/h}$
- C. 心电图出现U波
- D. 血清肌酐值正常
- E. 血pH值 >7.35

答案：B

解析：补钾的首要安全条件是尿量 $>40\text{ml/h}$ （「见尿补钾」），以确保肾脏有足够排钾能力，防止补钾后发生致命性高钾血症。

📖 教材P12

100. [A1型] [记忆] 少尿的定义是24小时尿量少于：

- A. 100ml
- B. 200ml
- C. 300ml
- D. 400ml
- E. 500ml

答案：D

解析：少尿定义为24小时尿量 $<400\text{ml}$ （或 $<17\text{ml/h}$ ）。无尿（尿闭）为 $<100\text{ml/d}$ 。多尿为 $>2500\text{ml/d}$ 。

📖 教材P12

101. [X型] [理解] 高钾血症的常见病因包括：

- A. 肾功能衰竭排钾减少
- B. 大量组织破坏释钾
- C. 代谢性酸中毒
- D. 长期使用保钾利尿剂
- E. 大量输注库存血

答案：ABCDE

解析：高钾血症病因：①肾排钾减少（急性肾衰竭、慢性肾衰竭终末期、醛固酮减少）；②细胞内钾移出（大量组织破坏如挤压综合征/溶血/大面积烧伤、酸中毒）；③摄入过多（大

量输注库存血、含钾药物、保钾利尿剂)。

教材P12

102. [A2型] [应用] 女性，65岁，因肠梗阻行胃肠减压5天，每日补充5%葡萄糖液2000ml。查体：皮肤弹性差，眼窝凹陷，BP 90/60mmHg。血钠128mmol/L。该患者电解质紊乱类型为：

- A. 等渗性缺水
- B. 高渗性缺水
- C. 低渗性缺水
- D. 高钾血症
- E. 低钾血症

答案：C

解析：长期胃肠减压丢失大量含钠消化液→只补葡萄糖液未补盐→钠丢失多于水→低渗性缺水（血钠128mmol/L，<135mmol/L）。皮肤弹性差和眼窝凹陷提示脱水程度已达中度。

教材P12

103. [A1型] [理解] 低渗性缺水时，体液变化的特点是：

- A. 细胞内液减少为主
- B. 细胞外液减少为主
- C. 细胞内液和细胞外液等比减少
- D. 体液向细胞内转移
- E. 体液无明显变化

答案：B

解析：低渗性缺水时细胞外液渗透压降低，水从细胞外液向渗透压相对较高的细胞内转移，导致细胞外液容量进一步减少（比单纯失水更严重），患者易发生休克。而细胞内液不但不减少反而增加。

教材P12

104. [A1型] [理解] 脱水程度按体重减轻分级，中度脱水的体重减轻范围为：

- A. 1%-3%
- B. 4%-6%
- C. 7%-10%
- D. 11%-15%
- E. >15%

答案：B

解析：脱水程度：轻度（体重减轻2-4%）、中度（体重减轻4-6%）、重度（体重减轻

>6%)。中度脱水临床表现为明显皮肤弹性减退、眼窝凹陷、尿量减少。

教材P12

105. [A2型] [应用] 男性，40岁，挤压伤后6小时入院，BP 80/50mmHg，HR 118次/分，尿量10ml/h（酱油色尿）。心电图示T波高尖。最紧急的处理是：

- A. 快速大量补液
- B. 静注10%葡萄糖酸钙
- C. 静脉注射胰岛素+葡萄糖
- D. 紧急血液透析
- E. 静脉注射碳酸氢钠

答案：B

解析：挤压综合征→横纹肌溶解→大量细胞内钾释放+急性肾功能衰竭排钾减少→严重高钾血症（T波高尖为高钾典型心电图改变）→有发生心脏骤停风险。最紧急处理是静脉注射钙剂（10%葡萄糖酸钙或氯化钙）以拮抗高钾对心肌的毒性，争取时间进行后续降钾治疗（胰岛素+葡萄糖、碳酸氢钠、透析等）。

教材P12

106. [X型] [应用] 低钾血症的临床表现包括：

- A. 肌无力
- B. 肠麻痹
- C. T波低平或倒置
- D. U波出现
- E. 代谢性碱中毒

答案：ABCDE

解析：低钾血症表现：①骨骼肌（四肢肌无力、腱反射减弱）；②平滑肌（肠麻痹、腹胀）；③心脏（心电图T波低平/倒置、U波、ST段下移）；④代谢性碱中毒（ K^+-H^+ 交换↑+肾泌 H^+ ↑→反常性酸性尿+代谢性碱中毒）。

教材P12

107. [A1型] [理解] 关于高渗性缺水，下列哪项是错误的？

- A. 血钠>150mmol/L
- B. 细胞外液高渗
- C. 主要丢失细胞内液
- D. 口渴感明显加重
- E. 应快速补充低渗盐水

答案：E

解析：高渗性缺水治疗应缓慢降低渗透压，补水为主（5%葡萄糖液或0.45%盐水）。快速补

充低渗盐水可导致脑水肿（细胞内渗透压仍高时，细胞外液渗透压急剧下降→水快速进入脑细胞→脑水肿），有脑疝风险。

📖 教材P12

108. [A1型] [理解] 正常血清钠浓度为：

- A. 120-130mmol/L
- B. 130-135mmol/L
- C. 135-145mmol/L
- D. 145-155mmol/L
- E. 155-160mmol/L

答案：C

解析：正常血清钠浓度为135-145mmol/L，是维持血浆渗透压的主要阳离子。血清钠异常（<135或>145）提示水钠代谢失衡。

📖 教材P12

输血（10题）

109. [A1型] [记忆] 术中输注红细胞的指征通常为：

- A. Hb<100g/L
- B. Hb<90g/L
- C. Hb<70g/L
- D. Hb<60g/L
- E. Hb<50g/L

答案：C

解析：术中输注红细胞的主要指征为Hb<70g/L（或Hct<21%）。Hb 70-100g/L时根据患者具体情况（年龄、心血管状态、出血速度等）决定是否输血。

📖 教材P30

110. [X型] [记忆] 自体输血的优点包括：

- A. 避免输血传播疾病
- B. 避免同种异体免疫反应
- C. 节约血源
- D. 降低输血费用
- E. 适用于所有手术患者

答案：ABCD

解析：自体输血优点：无输血传播疾病风险（肝炎、HIV等）、无同种异体免疫反应（溶血反应、过敏反应等）、节约血源、降低住院费用。但并非所有手术患者都适用，需满足一定

适应证（如Hb>110g/L、择期手术等）。

教材P30

111. [A1型] [记忆] 预存式自体输血适应证中，术前血红蛋白要求不低于：

- A. 80g/L
- B. 90g/L
- C. 100g/L
- D. 110g/L
- E. 120g/L

答案：D

解析：预存式自体输血要求患者术前Hb≥110g/L（或Hct≥33%），以确保患者能耐受采血且不影响围手术期氧供。

教材P30

112. [A1型] [记忆] 输注血小板的指征（手术患者）是血小板计数低于：

- A. $100 \times 10^9/L$
- B. $80 \times 10^9/L$
- C. $50 \times 10^9/L$
- D. $30 \times 10^9/L$
- E. $20 \times 10^9/L$

答案：C

解析：手术或有创操作时血小板输注指征为Plt< $50 \times 10^9/L$ 。无明显出血的内科患者Plt< $10-20 \times 10^9/L$ 时可输注。神经外科或眼科手术可能需要更高阈值（Plt< $100 \times 10^9/L$ ）。

教材P30

113. [A1型] [理解] 大量输血后出现创面渗血不止，最主要的原因是：

- A. 枸橼酸致低钙血症
- B. 稀释性PLT减少和凝血因子缺乏
- C. 输入血致高钾血症
- D. 代谢性碱中毒
- E. 大量输血致枸橼酸中毒

答案：B

解析：大量输注库存血后渗血原因：①库存血中血小板已失活→稀释性血小板减少；②库存血中不稳定凝血因子（V、VIII因子）已丧失活性→凝血因子缺乏；③失血性休克本身消耗凝血因子和血小板。三者共同导致凝血功能障碍。

教材P30

114. [X型] [理解] 大量输血后渗血原因的叙述，正确的是：

- A. 库存血中血小板数量和功能丧失
- B. 凝血因子 V 和 VIII 缺乏
- C. 枸橼酸中毒导致凝血障碍
- D. 低体温影响凝血酶活性
- E. 低钙血症参与其中

答案：ABDE

解析：大量输血后渗血是多因素综合作用：稀释性血小板减少、凝血因子缺乏（V/VIII）、低体温（抑制凝血酶和血小板功能）、低钙血症（大量枸橼酸抗凝剂输入结合血钙）。枸橼酸中毒本身主要表现为低钙症状（口周麻木、抽搐、心律失常），而非直接导致凝血障碍。

教材P30

115. [A2型] [应用] 患者脾破裂术中大出血，输注悬浮红细胞12U和血浆800ml后，创面出现广泛渗血，血小板计数降至 $40 \times 10^9/L$ ，PT延长至18秒（对照12秒）。下一步处理是：

- A. 继续输注红细胞
- B. 输注PLT和冷沉/新鲜冰冻血浆
- C. 使用止血药物
- D. 使用纤维蛋白原制剂
- E. 临床观察等待

答案：B

解析：大量输血后稀释性血小板减少（ $40 \times 10^9/L < 50 \times 10^9/L$ 的手术指征）合并凝血因子缺乏（PT延长），应同时补充血小板和凝血因子（冷沉淀含VIII因子、纤维蛋白原，FFP含所有凝血因子）。单纯使用止血药物不能解决血小板和凝血因子缺陷。

教材P30

116. [A1型] [理解] 输注库存血时，下列哪种并发症与枸橼酸中毒有关：

- A. 高钾血症
- B. 低钙血症
- C. 代谢性酸中毒
- D. 低体温
- E. 过敏反应

答案：B

解析：库存血中含枸橼酸钠抗凝剂，大量输入后枸橼酸与血中游离钙结合→低钙血症。临床表现为口周麻木、肌肉抽搐、QT间期延长，严重时可致心律失常。

教材P30

117. [A1型] [应用] 输注1U悬浮红细胞通常可使成人血红蛋白升高约：

- A. 1g/L

- B. 3g/L
- C. 5g/L
- D. 10g/L
- E. 15g/L

答案：C

解析：输注1U悬浮红细胞（约200ml）可使成人血红蛋白升高约5g/L（或Hct升高约3%）。临床用于估算红细胞输注量。

 教材P30

118. [A1型] [理解] 关于预存式自体输血，下列哪项是错误的？

- A. 适用于择期大手术
- B. 术前Hb $\geq$ 110g/L采血
- C. 采血间隔至少3天
- D. 最后1次采血应在术前72小时
- E. 可同时补充铁剂促进造血

答案：D

解析：预存式自体输血最后1次采血应在术前72小时之后（而非72小时内），以保证患者有充足时间恢复血容量。通常术前3周开始采血，间隔不少于3天。

 教材P30

肿瘤（4题）

119. [A1型] [记忆] 对化疗最敏感的肿瘤是：

- A. 肝癌
- B. 胃癌
- C. 绒毛膜癌
- D. 肾癌
- E. 胰腺癌

答案：C

解析：对化疗高度敏感的肿瘤包括绒毛膜癌、白血病、淋巴瘤、睾丸精原细胞瘤等。肝癌、胃癌、肾癌、胰腺癌对化疗相对不敏感。

 教材P145

120. [X型] [记忆] 对化疗高度敏感的肿瘤包括：

- A. 绒毛膜癌
- B. 急性淋巴细胞白血病
- C. 霍奇金淋巴瘤

- D. 睾丸精原细胞瘤
- E. 黑色素瘤

答案：ABCD

解析：化疗高度敏感肿瘤：绒毛膜癌、急性白血病（尤其ALL）、霍奇金淋巴瘤、非霍奇金淋巴瘤（部分亚型）、睾丸精原细胞瘤等。黑色素瘤对化疗不敏感，主要依赖免疫治疗和靶向治疗。

 教材P145

121. [A1型] [理解] 动脉瘤破裂后最严重的继发病变是：

- A. 血栓形成
- B. 假性动脉瘤形成
- C. 失血性休克
- D. 周围组织压迫
- E. 穿刺点感染

答案：C

解析：动脉瘤破裂后大量血液涌入体腔或组织间隙，迅速导致失血性休克，是动脉瘤破裂最致命、最紧急的并发症，需立即手术止血。假性动脉瘤为慢性破裂后周围组织包裹形成，相对稳定。

 教材P145

122. [A1型] [理解] 动脉瘤破裂后形成的假性动脉瘤，其瘤壁由什么组成：

- A. 完整的动脉壁三层结构
- B. 仅内膜层
- C. 仅外膜层
- D. 周围纤维组织和血栓
- E. 中膜和外膜

答案：D

解析：假性动脉瘤是动脉壁破裂后，血液经破口流入周围组织，被周围纤维组织包裹形成的搏动性血肿。其瘤壁为周围纤维组织和血栓机化形成，不含正常动脉壁的三层结构，这是与真性动脉瘤的本质区别。

 教材P145

麻醉前用药（4题）

123. [A1型] [记忆] 麻醉前用药的主要目的不包括：

- A. 镇静消除焦虑

- B. 减少呼吸道分泌物
- C. 抑制不良神经反射
- D. 增强麻醉镇痛效果
- E. 升高血压预防术中低血压

答案：E

解析：麻醉前用药目的：镇静解除焦虑、减少呼吸道分泌（干燥剂如阿托品）、抑制不良反射（迷走神经反射）、辅助镇痛、降低基础代谢率、预防过敏反应。升高血压并非用药目的。

 教材P75

124. [X型] [记忆] 麻醉前用药的目的包括：

- A. 镇静和解除焦虑
- B. 减少呼吸道分泌物
- C. 抑制迷走神经反射
- D. 降低基础代谢率
- E. 增强麻醉效果

答案：ABCDE

解析：麻醉前用药目的包括：镇静抗焦虑（苯二氮卓类）、减少呼吸道分泌（抗胆碱药）、抑制不良神经反射、降低基础代谢率、辅助镇痛增强麻醉效果、预防过敏。

 教材P75

125. [A1型] [理解] 麻醉前使用阿托品的主要目的是：

- A. 镇静催眠作用
- B. 减少分泌物抑制迷走反射
- C. 增强镇痛效果
- D. 预防过敏反应
- E. 升高外周血压

答案：B

解析：阿托品为抗胆碱能药物，麻醉前使用主要目的：①减少唾液和呼吸道分泌物（保持气道干燥通畅）；②抑制插管或手术牵拉引起的迷走神经反射（如心动过缓、喉痉挛）。

 教材P75

126. [A1型] [理解] 关于麻醉前用药，下列哪项叙述是错误的？

- A. 咪达唑仑常用于镇静
- B. 阿托品可减少呼吸道分泌
- C. 哌替啶可辅助镇痛
- D. 东莨菪碱仅有镇静作用
- E. 苯海拉明用于预防过敏

答案：D

解析：东莨菪碱为抗胆碱药，除减少呼吸道分泌和抑制迷走反射外，还有中枢镇静和遗忘作用，并非仅有镇静作用。阿托品与之相比中枢作用较弱。

📖 教材P75

局部麻醉（6题）

127. [A1型] [记忆] 下列局麻药中属于酰胺类的是：

- A. 普鲁卡因
- B. 丁卡因
- C. 利多卡因
- D. 可卡因
- E. 氯普鲁卡因

答案：C

解析：酰胺类局麻药包括利多卡因、布比卡因、罗哌卡因等（化学名中有两个「i」）。酯类包括普鲁卡因、丁卡因、可卡因、氯普鲁卡因（化学名中有一个「i」）。

📖 教材P80

128. [A1型] [记忆] 利多卡因单次使用的最大剂量（不含肾上腺素）是：

- A. 200mg
- B. 300mg
- C. 400mg
- D. 500mg
- E. 600mg

答案：C

解析：利多卡因单次使用最大剂量为400mg（不含肾上腺素时），含肾上腺素时为500mg（因肾上腺素收缩血管延缓吸收）。

📖 教材P80

129. [X型] [记忆] 下列属于酯类局麻药的有：

- A. 普鲁卡因
- B. 丁卡因
- C. 利多卡因
- D. 罗哌卡因
- E. 布比卡因

答案：AB

解析：酯类局麻药：普鲁卡因、丁卡因（的卡因）、可卡因、氯普鲁卡因。酰胺类：利多卡

因、布比卡因、罗哌卡因。鉴别记忆：酰胺类含两个「i」（如lidocaine、bupivacaine）。

📖 教材P80

130. [A1型] [理解] 布比卡因的最大剂量约为：

- A. 50mg
- B. 100mg
- C. 150mg
- D. 200mg
- E. 250mg

答案：C

解析：布比卡因单次最大剂量为150mg（约2mg/kg），其心脏毒性较其他局麻药大，过量可致难治性心律失常。罗哌卡因最大剂量约200-250mg，心脏毒性较布比卡因小。

📖 教材P80

131. [A2型] [应用] 男性，30岁，在局麻下行脂肪瘤切除术，使用1%利多卡因共30ml。术中患者突然出现口周麻木、耳鸣、意识模糊、肌肉抽搐。最可能的诊断是：

- A. 过敏性休克
- B. 局麻药中毒反应
- C. 血管迷走反应
- D. 癫痫发作
- E. 低血糖反应

答案：B

解析：30ml 1%利多卡因=300mg，虽未超极量(400mg)，但若误入血管或吸收过快仍可中毒。典型中毒顺序：口周麻木→耳鸣→意识模糊→肌肉抽搐→惊厥→昏迷→呼吸循环抑制。此为局麻药中枢神经系统毒性反应的典型表现。

📖 教材P80

132. [A1型] [应用] 预防局麻药毒性反应的最重要措施是：

- A. 使用最小有效浓度和剂量
- B. 加用肾上腺素
- C. 术前使用苯二氮卓类药物
- D. 注射前回抽防止误入血管
- E. 缓慢分次注射

答案：D

解析：预防局麻药中毒最重要措施是注射前回抽确认针尖不在血管内，防止将局麻药直接注入血管。其他措施（最小有效剂量、加肾上腺素延缓吸收、缓慢注射等）也是辅助预防

手段，但防止血管内注射是最关键的。

📖 教材P80

椎管内麻醉（17题）

133. [A1型] [记忆] 椎管内麻醉最适用于：

- A. 颅脑手术
- B. 颈部手术
- C. 胸部手术
- D. 下腹部及下肢手术
- E. 上腹部手术

答案：D

解析：椎管内麻醉（腰麻和硬膜外麻醉）最适用于下腹部、盆腔、会阴部和下肢手术。颅脑、颈部、胸部和上腹部手术通常需全麻。

📖 教材P85

134. [X型] [记忆] 硬膜外麻醉的禁忌证包括：

- A. 低血容量休克
- B. 穿刺部位感染
- C. 凝血功能障碍
- D. 颅内压增高
- E. 脊柱严重畸形

答案：ABCDE

解析：硬膜外麻醉禁忌证：①休克（交感阻滞可致血压进一步降低）；②穿刺部位感染；③凝血功能障碍（可致硬膜外血肿）；④颅内压增高（硬膜穿刺可诱发脑疝）；⑤脊柱严重畸形影响穿刺。

📖 教材P85

135. [A1型] [理解] 硬膜外麻醉最严重的并发症是：

- A. 低血压
- B. 硬膜外血肿
- C. 全脊麻
- D. 神经损伤
- E. 硬膜外腔感染

答案：C

解析：全脊麻是硬膜外麻醉最严重的并发症，发生在硬膜外导管误入蛛网膜下腔或硬膜被穿破后大量局麻药注入蛛网膜下腔时，可致全部脊神经广泛阻滞→呼吸停止+严重低血压→

如不及时处理可致心脏骤停。

教材P86

136. [A1型] [记忆] 腰麻穿刺成功的标志是：

- A. 阻力消失感
- B. 硬膜外负压现象
- C. 清亮脑脊液自穿刺针流出
- D. 患者诉下肢麻木
- E. 注射后迅速出现麻醉平面

答案：C

解析：腰麻穿刺成功的直接指征是清亮脑脊液自穿刺针流出。阻力消失感和负压现象是硬膜外穿刺成功的标志（穿刺针进入硬膜外腔的标志）。

教材P85

137. [A1型] [记忆] 腰麻后最常见的并发症是：

- A. 术后尿潴留
- B. 蛛网膜下腔阻滞头痛
- C. 体位性低血压
- D. 神经损伤
- E. 硬膜外血肿

答案：B

解析：腰麻后头痛是最常见的并发症，由硬脊膜穿破后脑脊液持续漏出→颅内压降低→脑组织下沉牵拉脑膜和神经引起。特征为坐起或站立时加重，平卧后减轻。

教材P86

138. [A1型] [理解] 腰麻后预防头痛的标准体位是：

- A. 平卧位
- B. 去枕平卧6小时
- C. 头低脚高位
- D. 半卧位
- E. 侧卧位

答案：B

解析：腰麻后常规去枕平卧6小时，目的是减少脑脊液从穿刺孔继续漏出，降低腰麻后头痛发生率。

教材P86

139. [A1型] [理解] 蛛网膜下腔阻滞期间发生恶心呕吐最常见的原因是：

- A. 局麻药过敏

- B. 低血压导致脑供血不足
- C. 迷走神经亢进
- D. 胃肠道牵拉反应
- E. 术前用药不良反应

答案：B

解析：腰麻后交感神经广泛阻滞→外周血管扩张→回心血量减少→低血压→脑灌注不足→呕吐中枢受刺激→恶心呕吐。为最常见原因。迷走神经亢进和高位腰麻抑制呼吸也可引起，但低血压是最主要的。

📖 教材P86

140. [A2型] [应用] 女性，45岁，在腰麻下行子宫肌瘤切除术。麻醉后15分钟，BP由120/80降至78/48mmHg，HR由80升至110次/分，伴恶心。最合理的处理是：

- A. 头低脚高位
- B. 加快输液并使用麻黄碱
- C. 立即气管插管
- D. 使用阿托品
- E. 停止手术

答案：B

解析：腰麻后交感神经阻滞→血管扩张→相对血容量不足→低血压+代偿性心率增快。处理：加快输液增加前负荷+麻黄碱（ $\alpha+\beta$ 受体激动剂）收缩血管和增加心输出量。头低脚高位可辅助增加回心血量。

📖 教材P86

141. [X型] [记忆] 硬膜外麻醉的并发症包括：

- A. 全脊麻
- B. 硬膜外血肿
- C. 神经损伤
- D. 局麻药中毒
- E. 硬膜外腔感染

答案：ABCDE

解析：硬膜外麻醉并发症：全脊麻（最严重）、硬膜外血肿（可致截瘫）、神经损伤、局麻药中毒（硬膜外血管丰富易吸收）、硬膜外腔感染或脓肿、低血压、导管折断等。

📖 教材P86

142. [A2型] [应用] 男性，55岁，L2-3间隙行硬膜外麻醉穿刺置管后，注入2%利多卡因5ml（试验量），5分钟后患者双下肢完全不能活动，呼吸费力。最可能发生了什么：

- A. 对局麻药过敏反应
- B. 硬膜外腔血肿
- C. 导管误入蛛网膜下腔致全脊麻
- D. 体位性低血压
- E. 高平面硬膜外阻滞

答案：C

解析：试验量（5ml 2%利多卡因）后迅速出现双下肢完全麻痹+呼吸费力，高度提示导管误入蛛网膜下腔，局麻药进入脑脊液导致全脊麻。高平面硬膜外阻滞5ml利多卡因通常不会在5分钟内导致如此广泛的阻滞。

📖 教材P86

143. [B1型] [理解] B1型题：椎管内麻醉并发症鉴别。共用选项：A. 脑脊液漏导致颅内压降低 B. 交感神经广泛阻滞 C. 局麻药误入蛛网膜下腔 D. 穿刺损伤脊髓或神经根 E. 硬膜外腔血管破裂出血。子题1：腰麻后头痛的发生机制是：

- A. 脑脊液漏导致颅内压减低
- B. 交感神经广泛阻滞
- C. 局麻药误入蛛网膜下腔
- D. 穿刺损伤脊髓或神经根
- E. 硬膜外腔血管破裂出血

答案：A

解析：腰麻后头痛的发生机制：硬脊膜穿刺孔→脑脊液持续漏出→颅内压降低→脑组织下沉牵拉脑膜和神经→头痛。

📖 教材P86

144. [B1型] [理解] 子题2：全脊麻的发生机制是：

- A. 脑脊液漏导致颅内压降低
- B. 交感神经广泛阻滞
- C. 局麻药误入蛛网膜下腔
- D. 穿刺损伤脊髓或神经根
- E. 硬膜外腔血管破裂出血

答案：C

解析：全脊麻是硬膜外麻醉导管误入蛛网膜下腔或将硬膜穿破后注药，局麻药全部进入脑脊液，导致全部脊神经甚至脑干被阻滞。

📖 教材P86

145. [B1型] [理解] 子题3：腰麻后低血压的主要发生机制是：

- A. 脑脊液漏导致颅内压降低

- B. 交感神经广泛阻滞
- C. 局麻药误入蛛网膜下腔
- D. 穿刺损伤脊髓或神经根
- E. 硬膜外腔血管破裂出血

答案：B

解析：腰麻后局麻药在蛛网膜下腔阻滞交感神经节前纤维→交感缩血管神经广泛阻滞→外周血管扩张→回心血量减少→低血压。

📖 教材P86

146. [A2型] [应用] 女性，60岁，在硬膜外麻醉下行全髋关节置换术。术后第2天出现双下肢麻木无力进行性加重。最可能的原因是：

- A. 体位性神经损伤
- B. 硬脊膜外血肿压迫
- C. 局麻药残留作用
- D. 术后疼痛限制活动
- E. 心理因素

答案：B

解析：硬膜外麻醉术后出现进行性加重的双下肢麻木无力，需高度警惕硬膜外血肿压迫脊髓。这是硬膜外麻醉严重并发症之一，需紧急MRI检查和手术减压。

📖 教材P86

147. [X型] [理解] 颈丛阻滞可能发生的并发症包括：

- A. 膈神经阻滞
- B. 喉返神经阻滞
- C. Horner综合征
- D. 全脊髓麻醉
- E. 声音嘶哑

答案：ABCDE

解析：颈丛阻滞并发症：①膈神经阻滞（呼吸困难）；②喉返神经阻滞（声音嘶哑）；③Horner综合征（颈交感神经阻滞：瞳孔缩小+眼睑下垂+面部无汗）；④局麻药误入椎动脉或蛛网膜下腔→全脊麻。

📖 教材P82

148. [A1型] [理解] 双侧颈丛阻滞应绝对禁止，主要原因是：

- A. 双侧喉返神经阻滞窒息
- B. 双侧膈神经阻滞呼吸困难
- C. 局麻药中毒风险增加一倍
- D. 技术性穿刺困难

- E. 术中患者不适

答案：B

解析：双侧颈丛阻滞可导致双侧膈神经阻滞→双侧膈肌麻痹→严重呼吸困难甚至窒息。单侧膈神经阻滞健侧膈肌可代偿，故双侧为绝对禁忌。

📖 教材P82

149. [A1型] [应用] 颈丛阻滞后出现同侧瞳孔缩小、眼睑下垂、面部无汗，提示：

- A. 喉返神经阻滞
- B. 膈神经被阻滞
- C. 颈交感阻滞Horner征
- D. 对局麻药过敏
- E. 急性脑血管卒中

答案：C

解析：Horner综合征（颈交感神经麻痹综合征）由颈交感神经链被阻滞引起，典型三联征：同侧瞳孔缩小、上睑下垂、面部无汗。是颈丛阻滞常见的并发症，通常为一过性。

📖 教材P82

气管插管与气道管理（17题）

150. [A1型] [记忆] 成人男性经口气管插管的适宜深度（门齿至导管尖端）为：

- A. 18-20cm
- B. 20-22cm
- C. 22-24cm
- D. 24-26cm
- E. 26-28cm

答案：C

解析：成人男性气管导管适宜深度为门齿处22-24cm，女性为20-22cm。插入过深易入右侧主支气管，过浅易脱出。

📖 教材P90

151. [X型] [记忆] 气管插管的禁忌证包括：

- A. 急性喉水肿
- B. 喉部异物
- C. 喉部肿瘤

- D. 严重凝血功能障碍
- E. 颈椎不稳定损伤(相对禁忌)

答案：ABCDE

解析：气管插管禁忌证：喉水肿、喉异物、喉部肿瘤（可导致完全堵塞）、严重凝血障碍（易致咽喉部血肿）、颈椎不稳定损伤（相对禁忌，插管时仰头可加重脊髓损伤）。

 教材P90

152. [X型] [记忆] 气管插管的并发症包括：

- A. 牙齿损伤
- B. 声带麻痹
- C. 喉水肿
- D. 导管误入食管
- E. 咽喉部软组织损伤

答案：ABCDE

解析：气管插管并发症：牙齿损伤或脱落、声带麻痹、喉水肿（尤其小儿）、导管误入食管（最危险）、咽喉部软组织损伤出血、构状软骨脱位、导管堵塞等。

 教材P90

153. [A1型] [理解] 全麻恢复期最常见导致上呼吸道梗阻的原因是：

- A. 喉水肿
- B. 舌后坠
- C. 声带麻痹
- D. 导管堵塞
- E. 导管打折

答案：B

解析：拔管后或意识不清患者最常见的上呼吸道梗阻原因是舌后坠。麻醉恢复期肌张力未完全恢复，舌肌松弛后坠堵塞咽部气道。托下颌或放置口咽通气管可解决。

 教材P90

154. [A1型] [记忆] 会厌的主要功能是：

- A. 喉部发声功能
- B. 吞咽时遮盖喉口防误吸
- C. 调节呼吸气流
- D. 舌体感受味觉
- E. 加温加湿空气

答案：B

解析：会厌是位于舌根与喉口之间的叶状结构。吞咽时会厌向后倾倒遮盖喉口，引导食团

进入食管而非气管，是防止误吸的重要解剖结构。

教材P90

155. [A1型] [记忆] 气管切开的主要适应证不包括：

- A. 上呼吸道机械性梗阻
- B. 需长期机械通气
- C. 下呼吸道分泌物潴留需清除
- D. 预防性气道保护
- E. 所有全麻手术

答案：E

解析：气管切开适应证：上呼吸道梗阻、需长期机械通气、需有效清除下呼吸道分泌物、预防性气道保护。并非所有全麻手术都需要气管切开。

教材P92

156. [X型] [理解] 气管导管留置期间常见的并发症包括：

- A. 导管堵塞
- B. 套囊漏气
- C. 误吸
- D. 导管移位
- E. 气管食管瘘

答案：ABCDE

解析：气管导管留置期间并发症：导管堵塞（痰痂/血痂）、套囊漏气、误吸（套囊上方分泌物下漏）、导管移位、长期留置可致气管软化或气管食管瘘。

教材P91

157. [A2型] [应用] 男性，50岁，全麻气管插管术后2小时，拔管后出现呼吸困难、三凹征、犬吠样咳嗽。最可能的原因是：

- A. 支气管痉挛
- B. 喉水肿
- C. 气胸
- D. 肺不张
- E. 肺栓塞

答案：B

解析：拔管后呼吸困难+三凹征+犬吠样咳嗽为喉水肿的典型表现，是气管插管常见并发症，多见于小儿和插管困难反复操作者。雾化吸入肾上腺素+糖皮质激素，严重时需重新插管。

教材P90

158. [A1型] [理解] 气管导管插入过深最常误入：

- A. 左主支气管
- B. 右主支气管
- C. 食管内
- D. 咽腔内
- E. 声门下

答案：B

解析：右主支气管与气管夹角较小（约25°）且管径较粗，气管导管插入过深最易滑入右主支气管，导致左肺不张和右肺过度通气。听诊左肺呼吸音减弱为早期线索。

教材P90

159. [A2型] [应用] 男性，65岁，气管切开留置套管1个月，近日进食呛咳，气囊充气后呛咳消失。最可能的并发症是：

- A. 气管食管瘘
- B. 喉返神经损伤
- C. 食管狭窄
- D. 气管软化
- E. 吞咽功能障碍

答案：A

解析：长期高气囊压力压迫气管后壁和食管前壁→缺血坏死→气管食管瘘。典型表现：进食呛咳，气囊充气后瘘孔被暂时堵塞使呛咳减轻。

教材P91

160. [B1型] [理解] B1型题：气道管理并发症定位。共用选项：A.舌后坠 B.喉水肿 C.导管误入食管 D.导管误入右主支气管 E.气管食管瘘。子题1：全麻恢复期出现鼾声，最常见原因是：

- A. 舌根后坠阻塞
- B. 急性喉水肿
- C. 导管误入食管
- D. 导管误入右主支气管
- E. 气管食管瘘

答案：A

解析：全麻恢复期肌张力未完全恢复→舌肌松弛后坠→咽部堵塞→鼾声。托下颌或放置口咽通气管可解决。

教材P90

161. [B1型] [理解] 子题2：插管后听诊仅右侧有呼吸音，左侧无呼吸音，原因是：

- A. 舌根后坠

- B. 急性喉水肿
- C. 导管误入食管
- D. 导管误入右主支气管
- E. 气管食管瘘

答案：D

解析：导管插入过深→滑入右主支气管→仅右肺通气→左肺无呼吸音。将导管退至适当深度后重新听诊确认。

📖 教材P90

162. [B1型] [应用] 子题3：插管后通气未见胸廓起伏，双肺无呼吸音，上腹部有气过水声，原因是：

- A. 舌根后坠
- B. 急性喉水肿
- C. 导管误入食管
- D. 导管误入右主支气管
- E. 气管食管瘘

答案：C

解析：插管误入食管最危险。表现：胸廓无起伏、双肺无呼吸音、上腹部逐渐隆起并有气过水声。需立即拔出导管重新面罩通气和插管。

📖 教材P90

163. [A1型] [应用] 气管导管套囊压力应维持在：

- A. 5-10mmHg
- B. 10-15mmHg
- C. 15-25mmHg
- D. 25-35mmHg
- E. 35-45mmHg

答案：C

解析：套囊压力应维持15-25mmHg（20-30cmH₂O），既能有效密封气道防止误吸，又不超过气管黏膜毛细血管灌注压（约30mmHg）以避免气管黏膜缺血坏死。

📖 教材P91

164. [A1型] [理解] 关于气管插管，下列哪项叙述是错误的？

- A. 成人男性插管深度为22-24cm
- B. 插管前须检查套囊完整性
- C. 经鼻插管较经口插管导管管径更粗
- D. 插管后须听诊确认导管位置
- E. 导管误入食管应立即拔出重插

答案：C

解析：经鼻插管因鼻腔限制需使用较细的导管（通常比经口小0.5-1mm内径），而非更粗。其余选项均正确。

 教材P90

165. [A1型] [应用] 插管后确认导管位置最可靠的方法是：

- A. 直接观察胸廓起伏
- B. 听诊双肺呼吸音
- C. 呼气末CO₂监测
- D. 观察导管内水蒸气
- E. 纤维支气管镜检查

答案：C

解析：ETCO₂监测是确认气管导管在气道内最快速、最可靠的方法。导管在气管内→呼出气含CO₂可检测到；误入食管则几乎无CO₂。

 教材P90

166. [A1型] [记忆] 喉罩通气道相对于气管插管的优点不包括：

- A. 操作更简便
- B. 对气道刺激更小
- C. 可有效防止误吸
- D. 不需要喉镜
- E. 心血管反应更轻

答案：C

解析：喉罩放置简便、刺激小、心血管反应轻，但不能完全防止误吸（不如气管插管套囊密封可靠），禁用于饱胃、反流高风险患者。

 教材P90

全身麻醉与药物相互作用（10题）

167. [A1型] [理解] 阿片类药物对吸入麻醉药MAC的影响是：

- A. 使MAC升高
- B. 使MAC降低
- C. MAC不变
- D. MAC先升后降
- E. 仅特定吸入药有影响

答案：B

解析：阿片类药物与吸入麻醉药有协同作用，可降低吸入麻醉药的MAC，减少达到同样麻

醉深度所需吸入药浓度，有助于减少吸入麻醉药用量和不良反应。

教材P95

168. [A1型] [理解] 吸入麻醉药与下列哪种药物合用时可显著增强肌松作用：

- A. 青霉素类
- B. 头孢菌素类
- C. 氨基糖苷类抗生素
- D. 大环内酯类
- E. 喹诺酮类

答案：C

解析：吸入麻醉药与氨基糖苷类抗生素（如庆大霉素、阿米卡星）有协同肌松作用，可显著增强肌松药效果或延长肌松时间。

教材P95

169. [X型] [理解] 吸入全麻药可能发生的药物相互作用包括：

- A. 与阿片类协同降低MAC
- B. 与氨基糖苷类协同增强肌松
- C. 与 β 受体阻滞剂协同抑制心肌
- D. 与茶碱类增加心律失常风险
- E. 与MAOI合用可致严重高血压

答案：ABCD

解析：吸入麻醉药相互作用：与阿片类协同降MAC、与氨基糖苷类协同肌松、与 β 阻滞剂协同抑制心肌、氟烷与茶碱类增加心律失常风险。MAOI风险主要与拟交感药相互作用，非吸入麻醉药本身。

教材P95

170. [A2型] [应用] 男性，60岁，有高血压病史长期服用美托洛尔。全麻诱导后出现严重低血压和心动过缓，对常规剂量麻黄碱和阿托品反应欠佳。最可能的原因是：

- A. 麻醉药物过敏
- B. 血容量不足
- C. β 阻滞剂与吸入麻醉药协同抑心血管
- D. 冠心病发作
- E. 急性肺血栓栓塞

答案：C

解析：长期服用 β 受体阻滞剂的患者，全麻诱导时吸入麻醉药或丙泊酚的负性肌力和扩血管作用与 β 阻滞的心肌抑制作用叠加，可致严重低血压和心动过缓，对常规剂量升压药反应欠

佳。

教材P95

171. [A1型] [理解] 高血压患者麻醉管理最重要的原则是：

- A. 术前停用所有降压药
- B. 维持血压稳定避免大幅波动
- C. 术中保持轻度低血压以减少出血
- D. 全部使用静脉麻醉
- E. 常规使用升压药预防低血压

答案：B

解析：高血压患者麻醉管理核心原则是维持血压稳定，避免大幅波动。血压过高可致脑出血/急性心衰，过低可致心脑血管灌注不足导致缺血。

教材P95

172. [A1型] [理解] 麻醉恢复期血压剧烈波动最常见的原因是：

- A. 血容量不足
- B. 疼痛刺激和麻醉深度减浅
- C. 低氧血症
- D. 高碳酸血症
- E. 术中低体温

答案：B

解析：麻醉恢复期血压波动最常见原因是麻醉减浅→交感神经活性恢复+疼痛刺激→儿茶酚胺释放增加→血压升高心率增快。有效镇痛和适当镇静是处理关键。

教材P95

173. [A1型] [记忆] MAC（最低肺泡有效浓度）的准确定义是：

- A. 全部患者达麻醉状态吸入浓度
- B. 50%患者对切皮无体动时的肺泡气浓度
- C. 患者呼吸停止的肺泡气浓度
- D. 产生最大肌松效果的吸入浓度
- E. 安全使用上限浓度

答案：B

解析：MAC定义为在1个大气压下，50%患者对手术切皮刺激无体动反应时的肺泡气吸入麻醉药浓度。MAC越小，麻醉药效价越强。

教材P95

174. [X型] [应用] 麻醉恢复期血压升高的处理措施包括：

- A. 充分镇痛

- B. 使用降压药物
- C. 保持气道通畅纠正缺氧
- D. 使用镇静药物
- E. 加快输液

答案：ABCD

解析：麻醉恢复期血压升高处理：充分镇痛（去除病因）、保持气道通畅纠正缺氧、必要时使用镇静或降压药。加快输液可能进一步升高血压，除非明确为容量不足。

📖 教材P95

175. [A1型] [理解] 氟烷麻醉中合用肾上腺素最可能引起：

- A. 严重高血压
- B. 严重室性心律失常
- C. 呼吸抑制
- D. 支气管痉挛
- E. 体温过高

答案：B

解析：氟烷可增加心肌对儿茶酚胺的敏感性，合用肾上腺素极易诱发严重室性心律失常。现代吸入麻醉药（七氟烷、地氟烷）此风险较低。

📖 教材P95

176. [A1型] [应用] 高血压患者术前降压药管理，下列哪项正确：

- A. 所有降压药均应停用至少1周
- B. β 受体阻滞剂应继续服用至术日晨
- C. 所有降压药继续服用无需调整
- D. 钙通道阻滞剂应停用
- E. 利尿剂应继续服用无需特殊处理

答案：B

解析： β 受体阻滞剂突然停药可致反跳性高血压和心肌缺血，应继续服用至术日晨。ACEI/ARB类可能导致术中顽固性低血压，部分指南建议术前停用。利尿剂可能引起低钾和低血容量，通常术前停用。

📖 教材P95

重症监测治疗及复苏（30题）

177. [A1型] [记忆] 双人心肺复苏时，胸外按压与人工呼吸的比例是：

- A. 单人15:2
- B. 单人15:2

- C. 成人30:2
- D. 成人30:2
- E. 连续按压不中断

答案：D

解析：成人双人或单人心肺复苏按压与通气比例均为30:2。建议每5个循环（约2分钟）轮换按压者以保证按压质量。

 教材P100

178. [A1型] [记忆] 成人心肺复苏时打开气道最常用的方法是：

- A. 仰头抬颏法
- B. 托下颌法
- C. 头后仰法
- D. 侧卧位
- E. 气管切开

答案：A

解析：仰头抬颏法是成人心肺复苏中最常用打开气道方法。怀疑颈椎损伤时使用托下颌法避免颈部过度后仰。

 教材P100

179. [A1型] [记忆] 心室细颤在电击除颤前应首先给予的药物是：

- A. 利多卡因
- B. 胺碘酮
- C. 肾上腺素
- D. 阿托品
- E. 碳酸氢钠

答案：C

解析：心室细颤时电击除颤成功率低，应先给予肾上腺素使细颤转变为粗颤后再电击。肾上腺素激动 α 受体→收缩外周血管→增加冠脉灌注压→改善心肌供血。

 教材P102

180. [X型] [记忆] 判断心搏骤停的主要依据包括：

- A. 意识突然丧失
- B. 大动脉搏动消失
- C. 呼吸停止
- D. 瞳孔散大
- E. 心音消失

答案：ABCE

解析：心搏骤停判断主要依据：意识突然丧失、大动脉搏动消失（颈动脉/股动脉）、呼吸停止或叹息样呼吸、心音消失。瞳孔散大通常在30-40秒后才出现，不作为主要判断依据。

📖 教材P100

181. [A1型] [记忆] 成人心肺复苏时胸外按压的深度应至少为：

- A. 2-3cm
- B. 3-4cm
- C. 5-6cm
- D. 6-7cm
- E. 超过7cm

答案：C

解析：成人胸外按压深度应至少5cm（约2英寸），但不超过6cm。按压过浅不能产生足够心输出量，按压过深增加骨折和内脏损伤风险。

📖 教材P100

182. [A1型] [记忆] 成人胸外按压频率应为：

- A. 60-80次/分
- B. 80-100次/分
- C. 100-120次/分
- D. 120-140次/分
- E. 超过140次/分

答案：C

解析：成人胸外按压频率为100-120次/分。频率过慢心输出量不足，频率过快则心脏充盈时间不足且按压深度往往不够。

📖 教材P100

183. [X型] [记忆] 心肺复苏的基本内容包括：

- A. 胸外按压
- B. 开放气道
- C. 人工呼吸
- D. 除颤
- E. 药物治疗

答案：ABCDE

解析：心肺复苏内容包括：C（胸外按压）-A（开放气道）-B（人工呼吸）-D（除颤）-药物治疗。按压是基础，除颤对可电击心律最重要，药物为辅助。

📖 教材P100

184. [A1型] [理解] 脑复苏的关键措施不包括：

- A. 维持脑灌注压
- B. 亚低温治疗
- C. 脱水降颅压
- D. 使用糖皮质激素
- E. 常规用高浓度葡萄糖液

答案：E

解析：脑复苏关键措施包括维持脑灌注压、亚低温、脱水降颅压（甘露醇）、激素。高血糖可加重缺血脑损伤，应避免常规使用高浓度葡萄糖液。

📖 教材P104

185. [X型] [理解] 脑复苏的综合措施包括：

- A. 维持有效脑灌注压
- B. 亚低温降低脑代谢
- C. 甘露醇脱水降颅压
- D. 糖皮质激素减轻脑水肿
- E. 控制血糖和电解质

答案：ABCDE

解析：脑复苏综合措施：维持脑灌注压、亚低温（32-34℃）、脱水降颅压（甘露醇）、糖皮质激素、控制血糖、纠正电解质紊乱、控制抽搐、防治感染。

📖 教材P104

186. [A1型] [记忆] 心电监护的适应证不包括：

- A. 器质性心脏病患者
- B. 大手术围手术期
- C. 休克状态
- D. 电解质紊乱
- E. 普通门诊患者

答案：E

解析：心电监护适用于心脏病患者、大手术围手术期、休克、严重电解质紊乱（尤其钾/钙异常）、严重创伤、心肺复苏后等。普通门诊患者无需心电监护。

📖 教材P108

187. [X型] [记忆] 现代麻醉学的任务包括：

- A. 临床麻醉
- B. 重症监测治疗
- C. 疼痛诊疗
- D. 急救复苏
- E. 围手术期医学

答案：ABCDE

解析：现代麻醉学已发展为围手术期医学，任务涵盖：临床麻醉、重症监测治疗（ICU）、疼痛诊疗、急救复苏和围手术期医学。

 教材P75

188. [A1型] [理解] 肾性急性肾衰竭最常见的病因是：

- A. 肾前性低灌注
- B. 肾后性梗阻
- C. 肾缺血和肾毒素
- D. 急性肾小球肾炎
- E. 间质性肾炎

答案：C

解析：肾性ARF最常见病因为肾缺血（休克、低灌注）和肾毒素（氨基糖苷类抗生素、造影剂、肌红蛋白等）导致的急性肾小管坏死（ATN），约占80-90%。

 教材P110

189. [A1型] [记忆] 择期手术前禁食固体食物的时间一般为：

- A. 2-4小时
- B. 4-6小时
- C. 6-8小时
- D. 8-12小时
- E. 12-24小时

答案：D

解析：择期手术术前禁食指南：固体食物8小时、牛奶和配方奶6小时、母乳4小时、清液（水、无渣果汁）2-4小时。目的是降低麻醉诱导时反流误吸风险。

 教材P76

190. [A1型] [记忆] 手术后伤口感染通常发生在术后：

- A. 2-3天
- B. 3-5天
- C. 7-10天
- D. 10-14天
- E. 24-48小时

答案：B

解析：术后伤口感染通常发生在术后3-5天，表现为切口红肿热痛加重、脓性分泌物、可伴发热和白细胞升高。术后24小时内发热多为非感染性（肺不张等）。

 教材P115

191. [A1型] [记忆] 静脉血栓形成的三大促发因素（Virchow三联征）不包括：

- A. 静脉血流淤滞
- B. 血管内膜损伤
- C. 血液高凝状态
- D. 动脉粥样硬化
- E. 无明显诱因

答案：D

解析：Virchow三联征：①血流淤滞（制动、心衰）；②血管内膜损伤（创伤、手术）；③血液高凝状态（肿瘤、妊娠）。动脉粥样硬化主要参与动脉血栓形成。

📖 教材P120

192. [X型] [记忆] 静脉血栓形成的易感因素包括：

- A. 高龄
- B. 肥胖
- C. 妊娠或产后
- D. 恶性肿瘤
- E. 长期制动

答案：ABCDE

解析：静脉血栓形成易感因素：高龄（>60岁）、肥胖（BMI>30）、妊娠和产后（高凝状态+子宫压迫）、恶性肿瘤（促凝物质释放）、长期制动（卧床/长途旅行）、手术、口服避孕药等。

📖 教材P120

193. [A1型] [理解] ICU危重患者最常见的心理健康问题是：

- A. 精神病
- B. 谵妄
- C. 人格障碍
- D. 躁狂发作
- E. 物质依赖

答案：B

解析：ICU谵妄是危重患者最常见的心理健康问题，发生率约30-80%。由多因素引起（缺氧、感染、药物、疼痛、睡眠剥夺、环境应激等），表现为急性波动性意识障碍。

📖 教材P108

194. [A1型] [理解] 床旁纤维支气管镜检查在ICU中的主要适应证是：

- A. 常规健康体检

- B. 肺不张和气道分泌物清除
- C. 肺部肿瘤筛查
- D. 支气管哮喘诊断
- E. 肺功能评估

答案：B

解析：ICU中床旁纤支镜主要用于：肺不张的检查和处理（直视下吸引解除堵塞）、气道分泌物采样（BAL）、气道异物取出、困难气道处理等。

📖 教材P108

195. [A1型] [理解] 深静脉导管尖端理想位置是：

- A. 锁骨下静脉
- B. 头臂静脉末端
- C. 上腔静脉与右心房交界处
- D. 右心房内
- E. 右心室内

答案：C

解析：深静脉导管尖端理想位置为上腔静脉与右心房交界处，此位置测得压力最准确反映右心房压。过深进入右心房可诱发心律失常，过浅在头臂静脉测得压力不可靠。

📖 教材P108

196. [X型] [理解] 危重患者心理健康的影响因素包括：

- A. 环境噪声光照节律紊乱
- B. 疼痛不适
- C. 药物影响
- D. 睡眠剥夺
- E. 与家人隔离

答案：ABCDE

解析：危重患者心理健康受多因素影响：ICU噪声和持续光照、疼痛和不适（各种管路操作）、镇静药物影响、睡眠剥夺（频繁监测干扰）、与家人隔离和社会支持缺失。

📖 教材P108

197. [A2型] [应用] 男性，70岁，腹部大手术后第3天，卧床未下床。突发呼吸困难、胸痛、咯血。查体：BP 90/60mmHg，HR 120次/分，SpO2 85%。最可能的原因是：

- A. 术后肺部感染
- B. 急性心肌梗死
- C. 肺血栓栓塞症
- D. 张力性气胸

- E. 急性心包填塞

答案：C

解析：高龄+大手术+术后制动（Virchow三联征高危）+突发呼吸困难/胸痛/咯血（肺栓塞典型三联征）+低血压+低氧=肺血栓栓塞症高度可能。

📖 教材P120

198. [X型] [理解] 术前评估应包括的内容有：

- A. 心脏功能和储备
- B. 肺功能评估
- C. 肝肾功能
- D. 凝血功能
- E. 营养状态

答案：ABCDE

解析：术前评估内容：心脏功能（病史+ECG+心超必要时）、肺功能、肝肾功能（药物代谢和排泄）、凝血功能、营养状态（白蛋白、体重变化）、气道评估、既往麻醉史等。

📖 教材P76

199. [A1型] [应用] 预防术后深静脉血栓形成的最有效措施是：

- A. 单纯使用弹力袜
- B. 早期下床+低分子肝素
- C. 单纯抗凝药物预防
- D. 术后严格卧床休息
- E. 单纯使用间歇充气加压装置

答案：B

解析：DVT预防最有效策略为综合措施：早期下床活动（消除血流淤滞）联合LMWH药物预防。弹力袜和间歇充气加压为辅助手段。术后绝对卧床反而增加DVT风险。

📖 教材P120

200. [A1型] [理解] 关于心肺复苏，下列哪项叙述是错误的？

- A. 按压频率100-120次/分
- B. 按压深度至少5cm
- C. 按压中断时间应尽量缩短
- D. 电击后应立即检查心律判断除颤效果
- E. 复苏期间应避免过度通气

答案：D

解析：电击除颤后应**立即继续胸外按压**（不间断2分钟），而非先检查心律。过分频繁的心律检查会显著减少按压时间，降低复苏成功率。按压中断应限制在10秒以内。

📖 教材P100

201. [A2型] [应用] 患者手术中突发室颤，经3次电击除颤后仍未恢复有效心律，持续胸外按压中。下一步首选的药物是：

- A. 利多卡因
- B. 胺碘酮
- C. 肾上腺素
- D. 阿托品
- E. 碳酸氢钠

答案：C

解析：室颤/无脉室速在电击除颤无效时，首选肾上腺素1mg静脉推注（每3-5分钟重复）。肾上腺素通过收缩外周血管增加冠脉和脑灌注压，改善除颤条件。胺碘酮为二线抗心律失常药。

 教材P102

202. [X型] [记忆] 床旁X线摄影在ICU中的优点包括：

- A. 无需搬运危重患者
- B. 可快速判断气管导管位置
- C. 可评估深静脉导管尖端位置
- D. 可发现气胸和肺不张
- E. 图像质量优于CT

答案：ABCD

解析：床旁X线优点：避免搬运危重患者、快速判断气管导管/深静脉导管位置和并发症（气胸、血胸、导管移位等）、发现气胸/肺不张/胸腔积液等。但图像质量不及CT。

 教材P108

203. [A1型] [分析] 心肺复苏中，终止复苏的可靠医学指标是：

- A. 瞳孔散大固定
- B. 脑死亡判定确立
- C. 复苏超过30分钟
- D. 持续无自主循环
- E. 家属要求停止

答案：B

解析：终止CPR的可靠医学依据是脑死亡判定确立（深昏迷+脑干反射消失+无自主呼吸）。单纯瞳孔散大、复苏时间>30分钟均非可靠终止指标——低体温、药物中毒时长时间复苏仍可能存活。

 教材P104

204. [A2型] [应用] 男性，70岁，心搏骤停经CPR 20分钟后ROSC（自主循环恢复）。目前昏迷，GCS 5分。脑复苏最应优先采取：

- A. 尽早高压氧治疗
- B. 亚低温目标温度管理32-36℃
- C. 大剂量糖皮质激素
- D. 预防性使用抗癫痫药物
- E. 高通气降低颅内压

答案：B

解析：ROSC后昏迷患者，目标温度管理（TTM，32-36℃维持≥24小时）是唯一被临床研究证实可改善神经预后的脑复苏措施，为指南I级推荐。

📖 教材P104

205. [A1型] [分析] 术后第2天患者突发单侧下肢肿胀、疼痛、皮温升高。最可能的诊断和最应警惕的并发症是：

- A. 下肢动脉栓塞→肢体坏疽
- B. 深静脉血栓形成→肺栓塞
- C. 淋巴水肿→象皮肿
- D. 筋膜间隙综合征→肌肉坏死
- E. 局部感染→败血症

答案：B

解析：术后早期+单侧下肢肿胀疼痛（DVT典型表现）→最应警惕肺栓塞（PE），因下肢近端DVT血栓脱落经下腔静脉→右心→肺动脉→可致致命性肺栓塞。DVT和PE是VTE的两个阶段。

📖 教材P120

206. [B1型] [应用] B1型题：术后并发症的处理。共用选项：A.保持气道通畅+面罩给氧 B.床旁X线+胸腔穿刺闭式引流 C.CTPA+抗凝治疗 D.心电图+心肌酶+心内科会诊 E.下肢血管超声+抗凝治疗。子题1：术后出现呼吸困难、低氧、胸痛、咯血，应行：

- A. 保持气道通畅+面罩给氧
- B. 床旁X线+胸腔穿刺闭式引流
- C. CT肺动脉造影+抗凝治疗
- D. 心电图+心肌酶+心内科会诊
- E. 下肢血管超声+抗凝治疗

答案：C

解析：术后呼吸困难+胸痛+咯血=肺栓塞高度可疑→紧急CTPA（螺旋CT肺动脉造影）+确诊或高度可疑时立即抗凝治疗（LMWH或普通肝素）。

📖 教材P120

颅内压增高（14题）

207. [A1型] [记忆] 成人颅内压的正常值为：

- A. 10-30mmH₂O
- B. 30-80mmH₂O
- C. 70-200mmH₂O
- D. 200-300mmH₂O
- E. 300-400mmH₂O

答案：C

解析：成人颅内压正常值：70-200mmH₂O（相当于5-15mmHg）。>200mmH₂O为颅内压增高。

 教材P200

208. [X型] [记忆] 颅内压增高的病因包括：

- A. 颅内占位性病变
- B. 脑水肿
- C. 脑积水
- D. 脑静脉回流受阻
- E. 良性颅内高压

答案：ABCDE

解析：颅内压增高病因：颅内占位性病变（肿瘤、血肿、脓肿）、脑水肿（血管源性/细胞毒性）、脑积水、脑静脉回流受阻（静脉窦血栓、颈内静脉受压）、良性（特发性）颅内高压。

 教材P200

209. [A1型] [记忆] 颅内压增高的三大主症是：

- A. 头痛、呕吐、视乳头水肿
- B. 头痛、发热、意识障碍
- C. 呕吐、偏瘫、失语
- D. 视乳头水肿、眼球震颤、共济失调
- E. 头痛、颈强直、发热

答案：A

解析：颅内压增高三大主症：①头痛（持续性进行性加重、清晨为重）；②呕吐（喷射性、与进食无关）；③视乳头水肿（眼底镜可见视盘边界模糊隆起）。

 教材P200

210. [A1型] [理解] 急性颅内压增高的Cushing反应表现为：

- A. 血压下降、脉搏增快、呼吸浅快

- B. 血压升高、脉搏减慢、呼吸深慢
- C. 血压升高、脉搏增快、呼吸浅快
- D. 血压下降、脉搏减慢、呼吸深慢
- E. 血压不变、脉搏增快、呼吸正常

答案：B

解析：Cushing反应：血压升高（脑干缺血→交感兴奋→外周血管收缩）、脉搏减慢（反射性迷走兴奋）、呼吸深慢（脑干受压）。是脑疝即将发生的危险信号。

📖 教材P200

211. [A1型] [理解] 良性颅内压增高的特征是：

- A. 存在明确的颅内占位病变
- B. 存在交通性脑积水
- C. 颅内压升高但无占位性病变和脑积水
- D. 存在明显的神经系统定位体征
- E. 脑脊液蛋白明显升高

答案：C

解析：良性（特发性）颅内压增高特征为颅内压增高（ $>200\text{mmH}_2\text{O}$ ）但无占位病变、无脑积水、脑脊液成分正常、无神经系统定位体征。多见于肥胖育龄女性。

📖 教材P202

212. [A1型] [记忆] 颅内压增高诊断性检查的首选是：

- A. 头颅X线平片
- B. 头颅CT
- C. 脑电图
- D. 经颅多普勒超声
- E. 脑血管造影

答案：B

解析：头颅CT是颅内压增高病因诊断的首选检查，可快速评估有无颅内占位、脑水肿、脑积水、中线移位等。眼底镜检查视乳头水肿可直接证实颅内压增高（床边无创）。

📖 教材P201

213. [A2型] [应用] 男性，35岁，头痛伴喷射性呕吐2周。查体：双侧视乳头水肿。头颅CT示右侧额叶占位伴中线移位。最应警惕的并发症是：

- A. 癫痫持续状态
- B. 脑疝形成
- C. 颅内感染
- D. 脑卒中
- E. 脑积水

答案：B

解析：颅内占位+中线移位+视乳头水肿=严重颅内压增高，最危险并发症为脑疝（尤其颞叶钩回疝或扣带回疝），可致昏迷、瞳孔不等大、呼吸循环骤停。需紧急降颅压和手术。

教材P200

214. [X型] [理解] 下列哪些检查可用于诊断颅内占位性病变：

- A. 头颅CT平扫+增强
- B. 头颅MRI平扫+增强
- C. 脑血管造影
- D. 眼底镜检查
- E. 脑电图检查

答案：ABC

解析：头颅CT和MRI可直接显示颅内占位病变位置大小和性质。脑血管造影评估肿瘤血供或血管性病变。眼底镜可发现视乳头水肿但不能直接诊断占位。脑电图评估脑功能状态而非占位诊断。

教材P201

215. [A1型] [应用] 颅内压增高患者腰穿的禁忌证是：

- A. 高度怀疑颅内感染
- B. 怀疑蛛网膜下腔出血
- C. 存在明显占位效应和中线移位
- D. 特发性良性颅内高压
- E. 正常颅压脑积水

答案：C

解析：存在明显颅内占位效应伴中线移位时腰穿为禁忌，因为腰穿放出脑脊液后椎管内压力降低，颅腔与椎管压力梯度增大→诱发脑疝（尤其枕骨大孔疝），可突然致死。

教材P201

216. [A2型] [应用] 女性，40岁，肥胖，近2个月间歇性头痛伴视物模糊。查体：双侧视乳头水肿。头颅CT和MRI未见占位和脑积水。腰穿压力为280mmH₂O。最可能的诊断是：

- A. 颅内肿瘤
- B. 脑积水
- C. 良性颅内压增高
- D. 假性脑瘤综合征
- E. 偏头痛

答案：C

解析：肥胖女性+颅内压增高+CT/MRI无占位和脑积水+腰穿压力升高=良性（特发性）颅内

压增高。假性脑瘤综合征通常继发于已知原因（药物、静脉窦血栓等）。

📖 教材P202

217. [A1型] [理解] 慢性颅内压增高在头颅X线平片上可见：

- A. 颅缝增宽
- B. 蝶鞍扩大鞍背骨质吸收
- C. 异常钙化
- D. 颅骨缺损
- E. 颅内积气征象

答案：B

解析：慢性颅内压增高在头颅X线平片上特征性表现为蝶鞍扩大和鞍背骨质吸收（由长期高压脑脊液搏动侵蚀所致），以及脑回压迹增多。颅缝增宽见于儿童（颅缝未闭）。

📖 教材P201

218. [A1型] [记忆] 关于颅内压增高，下列哪项叙述是错误的？

- A. 正常值为70-200mmH₂O
- B. 三大主症为头痛呕吐视乳头水肿
- C. 甘露醇是常用降颅压药物
- D. 腰穿放脑脊液是快速降颅压的首选方法
- E. Cushing反应提示脑疝即将发生

答案：D

解析：腰穿放脑脊液在颅内占位性病变伴中线移位时可能诱发脑疝，不是快速降颅压的安全首选方法。快速降颅压首选甘露醇或甘油果糖静脉输注。

📖 教材P200

219. [A1型] [应用] 甘露醇降颅压的最佳给药方式是：

- A. 持续静脉滴注
- B. 快速静脉推注
- C. 肌肉注射
- D. 经口经口口服给药给药
- E. 皮下注射

答案：B

解析：甘露醇降颅压需快速静脉推注（15-30分钟内输入），以迅速提高血浆渗透压→在血-脑屏障两侧形成渗透梯度→将脑组织中水「拉入」血管内→降低颅内压。缓慢滴注无法形成有效渗透梯度。

📖 教材P200

220. [A1型] [理解] 颅内压增高时脑血管的自动调节功能：

- A. 脑血管脑血管反应增强反应
- B. 脑血流基本脑血流基本不变
- C. 受损或丧失
- D. 仅在收缩压改变时发挥作用
- E. 主要依赖交感神经控制

答案：C

解析：严重颅内压增高时脑血管自动调节功能受损或丧失，脑血流被动地随体循环血压变化，血压升高→脑血流增多→脑水肿加重→颅内压进一步升高→恶性循环。

📖 教材P200

脑疝（8题）

221. [A1型] [记忆] 脑疝形成的根本条件是：

- A. 颅脑外伤
- B. 颅内肿瘤
- C. 颅腔内压力分布不均衡
- D. 脑组织水肿
- E. 梗阻性脑积水

答案：C

解析：脑疝形成的根本条件是颅腔内各部分压力分布不均衡，导致脑组织从高压区向低压区移位，被挤入硬膜间隙或颅骨孔道。外伤、肿瘤、水肿、积水均为可能导致压力不均的原因。

📖 教材P204

222. [A1型] [记忆] 颞叶钩回疝（小脑幕切迹疝）最具特征性的体征是：

- A. 双侧瞳孔缩小
- B. 同侧瞳孔先缩小后散大
- C. 双侧瞳孔散大
- D. 双侧双侧眼球固定
- E. 对侧瞳孔散大

答案：B

解析：颞叶钩回疝特征性体征为同侧瞳孔先短暂缩小（动眼神经受刺激）→随后散大（动眼神经副交感纤维受压迫麻痹），对光反射消失。伴对侧肢体偏瘫（大脑脚受压）和进行性意识障碍。

📖 教材P204

223. [A1型] [理解] 枕骨大孔疝最危险的临床表现是：

- A. 剧烈头痛
- B. 颈项强直
- C. 突然呼吸停止
- D. 血压升高
- E. 瞳孔缩小

答案：C

解析：枕骨大孔疝时小脑扁桃体被挤入枕骨大孔压迫延髓呼吸中枢，可致突然呼吸停止，是脑疝中最致命的形式。患者可在神志尚清醒的情况下突发呼吸骤停，抢救窗口极短。

📖 教材P204

224. [X型] [记忆] 脑疝的紧急处理措施包括：

- A. 快速静脉推注甘露醇
- B. 保持气道通畅和充分氧供
- C. 紧急手术减压
- D. 过度换气降低PaCO₂
- E. 腰穿放脑脊液

答案：ABCD

解析：脑疝紧急处理：快速静脉推注甘露醇（降颅压）、保持气道通畅充分氧供、过度换气（PaCO₂降至30-35mmHg→脑血管收缩→暂时降颅压）、紧急开颅手术减压。腰穿为禁忌。

📖 教材P205

225. [A2型] [应用] 男性，30岁，车祸后2小时。GCS由12降至7，右侧瞳孔散大固定，左侧肢体偏瘫。最可能的诊断是：

- A. 弥漫性轴索损伤
- B. 右颞叶钩回疝
- C. 左侧颞叶钩回疝
- D. 枕骨大孔疝
- E. 大脑镰下疝

答案：B

解析：意识障碍进行性加深+右侧瞳孔散大+左侧肢体偏瘫=右侧颞叶钩回疝（右侧动眼神经受压→右侧瞳孔散大，右侧大脑脚受压→对侧左侧肢体偏瘫）。需紧急降颅压和手术。

📖 教材P204

226. [B1型] [分析] B1型题：脑疝类型鉴别。共用选项：A.大脑镰下疝 B.颞叶钩回疝 C.枕骨大孔疝 D.蝶骨嵴疝 E.小脑蚓部上疝。子题1：瞳孔不等大+对侧偏瘫+意识障碍进行性加深，最常见于：

- A. 大脑镰下疝

- B. 钩回疝
- C. 枕骨大孔疝
- D. 蝶骨嵴疝
- E. 小脑蚓部上疝

答案：B

解析：瞳孔不等大+对侧偏瘫+意识障碍=颞叶钩回疝经典三联征。压迫动眼神经→同侧瞳孔散大；压迫大脑脚→对侧偏瘫。

📖 教材P204

227. [B1型] [分析] 子题2：突发呼吸停止为首发表现，之前可能仅有枕颈部疼痛，最常见于：

- A. 大脑镰下疝
- B. 颞叶钩回疝
- C. 枕骨大孔疝
- D. 蝶骨嵴疝
- E. 小脑蚓部上疝

答案：C

解析：枕骨大孔疝以呼吸突然停止为首发或特征性表现，延髓呼吸中枢受压。此前可仅有枕颈部疼痛和颈强。瞳孔改变出现较晚。

📖 教材P204

228. [A1型] [理解] 脑疝急救中过度通气治疗的主要机制是：

- A. 增加脑组织氧供
- B. 降低PaCO₂收缩脑血管减脑容量
- C. 升高血压增加脑灌注
- D. 降低脑代谢率
- E. 改善脑脊液循环

答案：B

解析：过度通气→PaCO₂降低→脑血管收缩→脑血容量减少→颅内压暂时降低。这是脑疝紧急处理的临时桥接措施（维持PaCO₂ 30-35mmHg），为甘露醇起效和手术准备争取时间。

📖 教材P205

颅脑损伤（21题）

229. [A1型] [记忆] 脑震荡的典型特征不包括：

- A. 伤后短暂意识障碍

- B. 典型逆行性遗忘
- C. 神经系统检查无阳性体征
- D. 头颅CT可见点状出血
- E. 脑脊液检查正常

答案：D

解析：脑震荡特征：伤后短暂意识障碍（<30分钟）、逆行性遗忘、神经系统检查无阳性体征、头颅CT和脑脊液检查均正常。CT有点状出血提示脑挫裂伤而非脑震荡。

📖 教材P208

230. [A1型] [记忆] 急性硬膜外血肿的典型CT表现是：

- A. 新月形高密度影
- B. 梭形（双凸镜形）高密度影
- C. 脑实质内高密度影
- D. 蛛网膜下腔高密度影
- E. 脑室内高密度影

答案：B

解析：急性硬膜外血肿CT特征为颅骨内板下梭形（双凸镜形）高密度影，不跨越颅缝。硬膜下血肿则为新月形，可跨越颅缝。

📖 教材P210

231. [A1型] [记忆] 急性硬膜外血肿最常见的出血来源是：

- A. 大脑前动脉
- B. 大脑中动脉
- C. 脑膜中动脉
- D. 上矢状窦
- E. 桥静脉

答案：C

解析：急性硬膜外血肿最常见出血来源为脑膜中动脉（或其分支）破裂，该动脉行经颞骨鳞部内面的脑膜中动脉沟，颞部骨折时极易损伤。因此硬膜外血肿好发于颞部。

📖 教材P210

232. [A1型] [记忆] 急性硬膜下血肿的出血来源主要是：

- A. 脑膜中动脉
- B. 大脑前动脉
- C. 桥静脉撕裂
- D. 椎动脉
- E. 颈内动脉

答案：C

解析：急性硬膜下血肿出血主要来源于脑表面至硬膜窦的桥静脉撕裂，常伴广泛脑挫裂伤，伤情较重。硬膜外血肿则主要来自脑膜中动脉。

📖 教材P210

233. [A1型] [理解] 急性硬膜外血肿的「中间清醒期」是指：

- A. 伤后一直清醒
- B. 伤后一直昏迷
- C. 昏迷→清醒→再昏迷
- D. 清醒→昏迷→清醒
- E. 持续嗜睡状态

答案：C

解析：中间清醒期是急性硬膜外血肿的特征性病程：原发性脑损伤后短暂昏迷→清醒期（血肿尚小未引起明显压迫）→血肿增大导致继发性脑受压→再次昏迷。是手术干预的最佳窗口。

📖 教材P210

234. [A1型] [记忆] 重型颅脑损伤的GCS评分为：

- A. 3-8分
- B. 5-10分
- C. 低于5分
- D. 9-12分
- E. 13-15分

答案：A

解析：GCS评分分级：轻型13-15分，中型9-12分，重型3-8分。重型颅脑损伤需立即气管插管保持气道通畅和呼吸支持，并紧急头颅CT检查。

📖 教材P208

235. [X型] [记忆] 颅底骨折的临床征象包括：

- A. 眶周皮下淤血（熊猫眼征）
- B. 脑脊液耳漏或鼻漏
- C. 乳突区Battle征
- D. 嗅觉丧失症
- E. 面神经麻痹

答案：ABCDE

解析：颅底骨折征象：前颅窝→熊猫眼征+脑脊液鼻漏+嗅神经损伤；中颅窝→脑脊液耳漏+面神经麻痹；后颅窝→乳突区Battle征+后组颅神经损伤。耳鼻漏为开放性颅脑损伤。

📖 教材P207

236. [A2型] [应用] 男性，25岁，车祸后头皮裂伤伴意识模糊。右眼眶周青紫肿胀，鼻腔有淡红色液体流出。最可能的诊断是：

- A. 单纯脑震荡
- B. 前颅窝骨折
- C. 中颅窝骨折
- D. 后颅窝骨折
- E. 面部软组织挫伤

答案：B

解析：眶周青紫（熊猫眼征）+鼻腔流出淡红色液体（脑脊液鼻漏）=前颅窝颅底骨折的典型表现。淡红色液体可用「晕环试验」或葡萄糖测定证实含CSF。

📖 教材P207

237. [A1型] [理解] 迟发性外伤性脑内血肿的特征是：

- A. 伤后立即出现血肿
- B. 首次CT正常，数小时至数天后见血肿
- C. 仅在老年人发生
- D. 血肿位于脑干
- E. 无需治疗可自行吸收

答案：B

解析：迟发性外伤性脑内血肿指伤后首次CT未发现脑内血肿，而在伤后数小时至数天内复查CT时新出现的脑内血肿。常见于伤后24-72小时，机制为挫伤区血管进行性损伤破裂。

📖 教材P211

238. [A2型] [应用] 男性，40岁，头部外伤后4小时入院，首次CT未见颅内出血。12小时后意识转差，复查CT示右额叶新发高密度灶。最可能的诊断是：

- A. 急性硬膜外血肿
- B. 急性硬膜下血肿
- C. 迟发性创伤性脑内血肿
- D. 脑组织挫裂伤
- E. 蛛网膜下腔出血

答案：C

解析：首次CT正常→12小时后意识转差→复查CT出现脑实质内高密度灶=典型的迟发性外伤性脑内血肿临床过程。对临床症状恶化的患者应及时复查CT。

📖 教材P211

239. [A1型] [理解] 海绵窦位于：

- A. 蝶鞍前方
- B. 蝶鞍两侧
- C. 枕骨大孔两侧
- D. 小脑幕上方
- E. 眼眶内

答案：B

解析：海绵窦位于蝶鞍两侧，是硬脑膜窦的重要组成部分。其内走行颈内动脉和第Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ₁、Ⅵ对颅神经。海绵窦病变可有特征性眼部表现。

📖 教材P207

240. [B1型] [理解] B1型题：颅底病变定位。共用选项：A.前颅窝 B.中颅窝 C.后颅窝 D.鞍区 E.海绵窦区。子题1：嗅觉丧失和脑脊液鼻漏，定位在：

- A. 前颅窝
- B. 中颅窝
- C. 后颅窝
- D. 鞍区
- E. 海绵窦区

答案：A

解析：前颅窝骨折：损伤嗅神经（Ⅰ）→嗅觉丧失；损伤筛板→脑脊液鼻漏。出现眶周皮下淤血（熊猫眼征）。

📖 教材P207

241. [B1型] [理解] 子题2：面神经麻痹和脑脊液耳漏，定位在：

- A. 前颅窝
- B. 中颅窝
- C. 后颅窝
- D. 鞍区
- E. 海绵窦区

答案：B

解析：中颅窝骨折：岩骨骨折→损伤面神经（Ⅶ）和听神经（Ⅷ）→面神经麻痹、听力障碍；损伤鼓室盖→脑脊液耳漏。

📖 教材P207

242. [B1型] [理解] 子题3：乳突区淤血（Battle征）和后组颅神经损伤，定位在：

- A. 前颅窝
- B. 中颅窝

- C. 后颅窝
- D. 鞍区
- E. 海绵窦区

答案：C

解析：后颅窝骨折：乳突区皮下淤血（Battle征），可损伤后组颅神经（IX-XII），出现吞咽困难、声音嘶哑、舌肌萎缩等。

📖 教材P207

243. [X型] [理解] 急性脑内血肿的临床表现包括：

- A. 意识障碍进行性加深
- B. 肢体偏瘫
- C. 颅内压增高
- D. 瞳孔改变
- E. 癫痫发作

答案：ABCDE

解析：急性脑内血肿临床表现取决于血肿大小和部位，包括：意识障碍进行性加深（血肿扩大和脑水肿）、偏瘫（血肿位于运动区或压迫内囊）、颅内压增高（头痛呕吐）、瞳孔改变（脑疝）、癫痫发作。

📖 教材P211

244. [A1型] [分析] 颅脑间接暴力伤最常见的类型是：

- A. 对冲性脑损伤
- B. 穿透性损伤
- C. 粉碎性骨折
- D. 凹陷性骨折
- E. 线性骨折

答案：A

解析：对冲性脑损伤是最常见的颅脑间接暴力伤：头部运动时突然受阻，脑组织因惯性在颅腔内移动→受力点对侧脑组织与颅骨碰撞→脑挫裂伤。如枕部着力→额叶和颞叶前部挫伤最为常见。

📖 教材P208

245. [A2型] [应用] 男性，50岁，酒后摔倒后枕部着地。查体：GCS 14分。CT示双侧额叶底部点状高密度影。此损伤类型为：

- A. 对冲性冲击伤
- B. 对冲性损伤
- C. 弥漫性轴索损伤
- D. 硬膜外血肿

- E. 蛛网膜下腔出血

答案：B

解析：枕部着地→对冲部位（额叶底部和颞极）出现损伤（CT高密度影为挫伤出血灶）=典型的对冲性脑损伤。枕部受力时脑在颅内向前移动，前颅窝底粗糙骨质与额极和颞叶摩擦碰撞。

📖 教材P208

246. [A1型] [记忆] GCS评分中睁眼反应的最高得分为：

- A. 3分
- B. 4分
- C. 5分
- D. 6分
- E. 7分

答案：B

解析：GCS评分三个维度：睁眼反应（1-4分）、语言反应（1-5分）、运动反应（1-6分）。总分3-15分。睁眼：自动睁眼4分→呼唤睁眼3分→刺痛睁眼2分→无反应1分。

📖 教材P208

247. [A1型] [分析] 关于原发性颅脑损伤伤情判断，下列哪项最为重要：

- A. 头皮损伤程度
- B. 颅骨骨折类型
- C. GCS评分联合瞳孔体征
- D. 伤口出血量
- E. 患者基础年龄

答案：C

解析：GCS评分量化意识障碍程度，联合瞳孔大小和对光反射（判断脑疝）及生命体征（Cushing反应）可全面评估颅脑损伤严重程度和动态变化趋势，指导治疗决策。

📖 教材P208

248. [A1型] [理解] 关于急性硬膜下血肿，下列哪项叙述是错误的？

- A. CT呈新月形高密度影
- B. 血肿可跨越颅缝
- C. 出血来源主要是桥静脉
- D. 典型表现为中间清醒期
- E. 常合并较重的脑挫裂伤

答案：D

解析：中间清醒期是急性硬膜外血肿的典型特征，而非硬膜下血肿。硬膜下血肿因常伴有

较重原发脑损伤，意识障碍呈进行性加重，无明显中间清醒期。

教材P210

249. [A1型] [记忆] 脑外伤后发生颅内感染，最常见的致病菌是：

- A. 肺炎链球菌
- B. 脑膜炎奈瑟菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 大肠埃希菌
- E. 流感嗜血杆菌

答案：C

解析：脑外伤后颅内感染最常见致病菌为金黄色葡萄球菌，与开放性颅脑损伤、手术等皮肤菌群污染途径一致。其次为G-杆菌（如绿脓杆菌、大肠埃希菌等）。

教材P225

脑水肿（4题）

250. [A1型] [记忆] 血管源性脑水肿的主要发生机制是：

- A. 细胞膜Na-K泵衰竭
- B. 血脑屏障破坏
- C. 脑脊液循环障碍
- D. 脑血管痉挛
- E. 脑静脉血栓形成

答案：B

解析：血管源性脑水肿是由于血脑屏障破坏，血浆成分（水和蛋白质）从血管内漏出到细胞外间隙。常见于脑肿瘤、脑脓肿、脑挫裂伤周围。细胞毒性脑水肿则因Na-K-ATP酶功能障碍。

教材P212

251. [A1型] [理解] 细胞毒性脑水肿最常见于：

- A. 脑肿瘤周围
- B. 脑缺血缺氧早期
- C. 脑脓肿周围
- D. 脑挫裂伤周围
- E. 高血压脑病

答案：B

解析：细胞毒性脑水肿最常见于脑缺血缺氧早期：缺血→ATP耗竭→Na-K-ATP酶功能障碍→细胞内Na潴留→水内流→细胞肿胀（主要是星形胶质细胞）。脑肿瘤和脓肿周围以血管源

性脑水肿为主。

教材P212

252. [X型] [记忆] 脑水肿的治疗措施包括：

- A. 甘露醇脱水
- B. 糖皮质激素
- C. 手术减压
- D. 控制血压
- E. 亚低温治疗

答案：ABCDE

解析：脑水肿治疗综合措施：①甘露醇或高渗盐水快速脱水；②糖皮质激素（尤其对血管源性脑水肿如肿瘤周围水肿有效）；③手术去骨瓣减压（恶性脑水肿）；④控制血压维持脑灌注；⑤亚低温降低脑代谢。

教材P212

253. [A1型] [应用] 糖皮质激素对哪种类型的脑水肿效果最好：

- A. 细胞毒性脑水肿（脑缺血）
- B. 血管源性脑水肿(肿瘤周围)
- C. 间质性脑水肿（脑积水）
- D. 渗透压性脑水肿
- E. 所有类型脑水肿效果相同

答案：B

解析：糖皮质激素（如地塞米松）对血管源性脑水肿效果最好，可减轻血脑屏障通透性和抑制炎症反应。对细胞毒性脑水肿效果差甚至可能有害（增加感染和高血糖风险）。

教材P212

脑干损伤与颅内感染（8题）

254. [A1型] [记忆] 脑干损伤最严重且最常见的直接死因是：

- A. 持续性持续性高热
- B. 应激性溃疡出血
- C. 呼吸衰竭
- D. 肺部感染
- E. 电解质紊乱

答案：C

解析：脑干损伤最严重并发症为呼吸衰竭，因脑干呼吸中枢（延髓）直接受损导致中枢性

呼吸节律异常甚至呼吸停止，是脑干损伤患者最常见的直接死因。

教材P213

255. [X型] [记忆] 脑干损伤常见的并发症包括：

- A. 呼吸衰竭
- B. 中枢性高热
- C. 应激性溃疡
- D. 肺部感染
- E. 深静脉血栓

答案：ABCDE

解析：脑干损伤并发症：呼吸衰竭（最致命）、中枢性高热（体温调节中枢损伤）、应激性溃疡（交感兴奋→胃黏膜缺血）、肺部感染（长期卧床+呼吸障碍）、深静脉血栓（长期制动）等。

教材P213

256. [A1型] [记忆] 中枢神经系统感染的三大来源不包括：

- A. 血源性（菌血症播散）
- B. 邻近感染灶直接扩散
- C. 直接种植（外伤或手术）
- D. 经呼吸道空气传播
- E. 无明显异常表现

答案：D

解析：中枢神经系统感染的三大来源：①血源性（远处感染灶经血行播散）；②邻近扩散（中耳炎、鼻窦炎）；③直接种植（开放性颅脑损伤、手术后）。空气传播不是颅内感染的典型途径。

教材P225

257. [X型] [记忆] 脑脓肿的感染途径包括：

- A. 血源性感染
- B. 邻近感染灶直接扩散
- C. 开放性颅脑伤后种植
- D. 隐源性感染
- E. 逆行性经神经感染

答案：ABCD

解析：脑脓肿感染途径：①血源性（远处感染经动脉播散）；②邻近扩散（中耳炎→颞叶或小脑脓肿、鼻窦炎→额叶脓肿）；③直接种植（开放伤、手术后）；④隐源性（找不到明确原发灶）。

教材P225

258. [X型] [记忆] 脑功能评价常用的手段包括：

- A. GCS昏迷评分
- B. 脑电图监测
- C. 诱发电位
- D. 经颅多普勒超声
- E. Glasgow结局量表（GOS）

答案：ABCDE

解析：脑功能评价手段：GCS（急性期意识障碍量化）、EEG（脑电活动评估）、诱发电位（感觉传导通路完整性）、TCD（脑血流评估）、GOS（长期预后评估，1-5级）。

教材P208

259. [A2型] [应用] 男性，45岁，开放性颅脑损伤清创术后1周，突发高热、剧烈头痛、颈项强直。腰穿见浑浊脑脊液，白细胞计数显著增加以中性粒细胞为主。最可能的诊断是：

- A. 病毒性脑膜炎
- B. 结核性脑膜炎
- C. 细菌性脑膜炎
- D. 真菌性脑膜炎
- E. 脑水肿加重

答案：C

解析：开放性颅脑损伤术后+高热/头痛/颈强直+脑脊液浑浊（化脓性改变）+中性粒细胞显著增高=细菌性（化脓性）脑膜炎。外伤后最常见致病菌为金黄色葡萄球菌。需紧急使用能透过血脑屏障的抗生素。

教材P225

260. [A1型] [理解] 脑干损伤后应激性溃疡（Cushing溃疡）的主要机制是：

- A. 胃酸分泌过多
- B. 胃黏膜缺血胃酸反向弥散
- C. 胃蛋白酶分泌过多
- D. 幽门螺杆菌感染
- E. 十二指肠胃胆汁反流

答案：B

解析：脑干损伤→交感神经极度兴奋→内脏血管收缩→胃黏膜缺血→黏膜屏障破坏→H⁺反向弥散→黏膜损伤加重→溃疡形成和出血（Cushing溃疡）。与普通消化性溃疡机制不同。

教材P213

261. [A1型] [应用] 预防颅脑损伤后应激性溃疡的首选药物是：

- A. 抗酸药（氢氧化铝）
- B. PPI/H₂受体拮抗剂
- C. 硫糖铝胃黏膜保护剂
- D. 米索前列醇制剂
- E. 全身止血药物

答案：B

解析：预防应激性溃疡首选PPI（如奥美拉唑）或H₂受体拮抗剂（如法莫替丁），通过抑制胃酸分泌减少H⁺反向弥散，保护受损的胃黏膜。重型颅脑损伤患者应常规预防。

📖 教材P213

颅内肿瘤及其他（10题）

262. [A1型] [记忆] 颅内最常见的原发性肿瘤是：

- A. 脑膜瘤
- B. 垂体瘤
- C. 胶质瘤
- D. 转移瘤
- E. 听神经瘤

答案：C

解析：胶质瘤是颅内最常见的原发性肿瘤（约占40-50%），来源于神经上皮组织（星形细胞、少突胶质细胞、室管膜细胞等）。脑膜瘤为第二位常见。

📖 教材P230

263. [A1型] [记忆] 小脑半球肿瘤最特征的体征是：

- A. 单侧肢体偏瘫
- B. 共济失调和眼球震颤
- C. 偏身感觉障碍
- D. 运动性失语症
- E. 同向视野缺损

答案：B

解析：小脑半球肿瘤特征性体征：患侧肢体共济失调（指鼻试验、跟膝胫试验阳性）、眼球震颤、肌张力降低、步态蹒跚。偏瘫、失语为大脑半球肿瘤体征。

📖 教材P231

264. [X型] [记忆] 颅内肿瘤的治疗原则包括：

- A. 手术切除为主
- B. 放射治疗

- C. 化学治疗
- D. 靶向治疗
- E. 对症支持治疗

答案：ABCDE

解析：颅内肿瘤治疗原则：①手术切除（首选，尽可能全切同时保留神经功能）；②放疗（肿瘤残余、恶性胶质瘤、转移瘤）；③化疗（替莫唑胺等）；④靶向治疗；⑤对症支持（激素减轻水肿、抗癫痫、康复）。

📖 教材P232

265. [A1型] [理解] 脑膜瘤的典型影像学特征不包括：

- A. CT平扫呈等高或略高密度
- B. 均匀明显强化
- C. 宽基底与硬膜相连
- D. 周围明显脑水肿为必备特点
- E. 可有硬膜尾征

答案：D

解析：脑膜瘤典型影像：CT等高或略高密度、均匀明显强化、宽基底与硬膜相连、「硬膜尾征」。周围脑水肿并非必备特征——小脑膜瘤可无水肿，大或侵袭性脑膜瘤可伴明显水肿。

📖 教材P230

266. [A1型] [理解] 烟雾病（Moyamoya病）的特征性治疗是：

- A. 抗血小板治疗
- B. 抗凝治疗
- C. 脑血管重建术
- D. 溶栓治疗
- E. 单纯药物治疗

答案：C

解析：烟雾病的特征性治疗为脑血管重建术（血管搭桥术），如颞浅动脉-大脑中动脉吻合术（STA-MCA bypass），通过建立颅外-颅内血供通路改善脑灌注，预防脑缺血和卒中。

📖 教材P235

267. [A2型] [应用] 女性，55岁，头痛伴左侧肢体无力进行性加重2个月。CT示右额叶类圆形等密度影，周围大片低密度区，注射造影剂后呈环状强化，中心不强化。最可能的诊断是：

- A. 脑膜瘤
- B. 胶质母细胞瘤
- C. 脑脓肿
- D. 脑转移瘤

- E. 淋巴瘤

答案：B

解析：脑实质内占位+环状强化+中心不强化（坏死）+周围大片水肿=胶质母细胞瘤（GBM）典型影像表现。脑脓肿也可环状强化但通常急性起病伴发热，转移瘤可多发，脑膜瘤为均匀强化。

📖 教材P230

268. [X型] [理解] 脑膜瘤的鉴别诊断主要包括：

- A. 硬膜转移瘤
- B. 血管外皮细胞瘤
- C. 孤立性纤维瘤
- D. 淋巴瘤
- E. 脑膜血管瘤病

答案：ABCDE

解析：脑膜瘤需与硬膜基底的病变鉴别：硬膜转移瘤、血管外皮细胞瘤（更侵袭性、易复发）、孤立性纤维瘤、淋巴瘤（多灶性）、脑膜血管瘤病（罕见、常伴癫痫）等。金标准为病理免疫组化。

📖 教材P230

269. [A1型] [应用] 胶质瘤术后放疗最常用的方式是：

- A. 全脑放疗
- B. 局部适形调强放疗
- C. 质子治疗
- D. 立体定向立体定向伽马刀
- E. 近距离放疗

答案：B

解析：胶质瘤术后标准放疗为肿瘤床（增强T1病灶外扩1.5-2.5cm）适形调强放疗（IMRT），总剂量约60Gy/30次。全脑放疗因认知功能损害大已少用。伽马刀主要用于小的残留或复发灶。

📖 教材P232

270. [A1型] [记忆] 关于颅内肿瘤，下列哪项叙述是错误的？

- A. 胶质瘤是最常见的原发性颅内肿瘤
- B. 脑膜瘤多起源于蛛网膜颗粒细胞
- C. 小脑半球肿瘤可有共济失调
- D. 所有颅内肿瘤都应首选放疗
- E. 颅内压增高是常见首发症状

答案：D

解析：颅内肿瘤治疗首选手术切除，而非所有都首选放疗。良性肿瘤（如脑膜瘤）手术全切后可能无需放疗。放疗主要适用于恶性程度高、手术残留或无法手术的患者。

📖 教材P232

271. [A1型] [理解] 功能性垂体瘤最常见的早期症状是：

- A. 反复发作性头痛
- B. 视力视野障碍
- C. 内分泌功能异常
- D. 脑脊液鼻漏
- E. 癫痫发作

答案：C

解析：功能性垂体瘤以相应激素过度分泌的内分泌症状为最早表现（如泌乳素瘤→闭经泌乳，GH瘤→肢端肥大）。无功能腺瘤早期可无症状，增大后压迫视交叉→双颞侧偏盲。

📖 教材P230

甲状腺疾病（17题）

272. [X型] [记忆] 甲亢的手术指征包括：

- A. 继发性甲亢或高功能腺瘤
- B. 抗甲状腺药物治疗无效或复发
- C. 甲状腺肿大伴明显压迫症状
- D. 胸骨后甲状腺肿伴甲亢
- E. 妊娠早期甲亢

答案：ABCD

解析：甲亢手术指征：继发性甲亢或高功能腺瘤、药物治疗无效或复发、压迫症状明显、胸骨后甲状腺肿。妊娠早期（前3个月）和晚期（后3个月）为手术禁忌，流产或早产风险高。

📖 教材P290

273. [X型] [记忆] 抗甲状腺药物治疗的适应证包括：

- A. 轻症甲亢
- B. 青少年甲亢
- C. 妊娠期甲亢
- D. 术前准备
- E. 甲状腺危象不宜手术者

答案：ABCDE

解析：抗甲状腺药物适应证：轻症甲亢、青少年（<20岁）、妊娠期甲亢（丙硫氧嘧啶首选）、术前准备（使甲状腺功能正常后再手术）、甲状腺危象不宜手术者、术后复发不愿再次手术者。

📖 教材P290

274. [A1型] [记忆] 甲状腺癌最常见的病理类型是：

- A. 滤泡状癌
- B. 乳头状癌
- C. 髓样癌
- D. 未分化癌
- E. 鳞状细胞癌

答案：B

解析：乳头状癌是甲状腺癌最常见的病理类型（约占80-85%），分化程度高、生长缓慢、预后最好（10年生存率>90%），易经颈部淋巴结转移但血行转移较少。

📖 教材P292

275. [A2型] [应用] 女性，35岁，发现颈部肿块1个月。查体：右叶甲状腺质硬结节，边界不清，活动度差，伴声音嘶哑。最可能的诊断是：

- A. 单纯性甲状腺肿
- B. 甲状腺腺瘤
- C. 甲状腺癌
- D. 亚急性甲状腺炎
- E. 桥本甲状腺炎

答案：C

解析：质硬结节+边界不清+活动度差+声音嘶哑（喉返神经受侵）=甲状腺癌高度可疑。良性结节通常质软、边界清楚、活动度好、无声嘶。需行超声和FNA进一步明确。

📖 教材P292

276. [A1型] [记忆] 单纯性（地方性）甲状腺肿最常见的原因是：

- A. 饮食碘缺乏
- B. 遗传因素
- C. 药物影响
- D. 病毒性甲状腺炎
- E. 自身免疫

答案：A

解析：碘缺乏是单纯性甲状腺肿最常见的原因。机制：碘不足→甲状腺激素合成减少

→TSH反馈性分泌增加→刺激甲状腺增生肥大。补碘是防治的根本措施。

教材P288

277. [A1型] [理解] 甲状旁腺激素（PTH）分泌的主要调节因素是：

- A. 血磷浓度
- B. 血钙浓度
- C. 降钙素
- D. 维生素D
- E. 促甲状腺激素

答案：B

解析：PTH分泌主要受血Ca²⁺浓度的负反馈调节：血钙降低→刺激PTH分泌→促进骨吸收、肾小管钙重吸收和1,25-(OH)₂D₃合成→血钙升高→抑制PTH分泌。血钙是最主要的调节因素。

教材P294

278. [A2型] [应用] 女性，45岁，甲状腺全切术后第2天，出现口周麻木、手指抽搐。Chvostek征阳性。最可能的原因是：

- A. 喉返神经损伤
- B. 甲旁减导致低钙血症
- C. 喉上神经损伤
- D. 术后甲状腺危象
- E. 颈部血肿压迫

答案：B

解析：甲状腺全切术后+口周麻木/手足抽搐+Chvostek征阳性（轻敲面神经时口角抽动）=典型甲状旁腺损伤/切除导致甲状旁腺功能减退→低钙血症。需静脉补钙和维生素D治疗。

教材P294

279. [X型] [记忆] 良性甲状腺结节的手术指征包括：

- A. 出现压迫症状
- B. 胸骨后甲状腺肿
- C. 可疑恶变
- D. 合并甲亢
- E. 结节随时间缩小

答案：ABCD

解析：良性甲状腺结节手术指征：出现压迫症状（呼吸困难/吞咽困难）、胸骨后甲状腺肿、可疑恶变、合并甲亢内科治疗无效。结节缩小（尤其自发缩小）通常提示良性过程，可继续观察。

教材P288

280. [X型] [理解] 甲状腺大部切除术后发生呼吸困难的原因包括：

- A. 切口出血形成血肿压迫
- B. 喉头水肿
- C. 气管塌陷
- D. 双侧喉返神经损伤
- E. 喉上神经损伤

答案：ABCD

解析：术后呼吸困难四大原因：①切口内出血→血肿压迫（最紧急，需床旁拆线减压）；②喉头水肿；③气管软化塌陷（长期甲状腺肿压迫）；④双侧喉返神经损伤→声带内收→气道梗阻。喉上神经损伤导致音调降低和饮水呛咳，不引起呼吸困难。

教材P291

281. [A2型] [应用] 女性，40岁，甲状腺大部切除术后4小时，出现呼吸困难和颈部肿胀。最紧急的处理是：

- A. 紧急紧急气管插管
- B. 床旁拆除伤口缝线探查止血
- C. 大剂量激素
- D. 局部局部雾化吸入
- E. 床旁床旁气管切开

答案：B

解析：甲状腺术后4小时+呼吸困难+颈部肿胀=高度提示切口内血肿形成并压迫气管。最紧急处理为床旁立即拆除缝线减压，排出积血，解除气道压迫。若延误可迅速致死。

教材P291

282. [A1型] [理解] 甲状腺癌最常见的转移途径是：

- A. 血行转移
- B. 颈部淋巴结转移
- C. 直接浸润
- D. 种植转移
- E. 脑脊液播散

答案：B

解析：乳头状甲状腺癌最常见颈部淋巴结转移（就诊时约50%已有颈部淋巴结转移），尤其同侧中央区（VI区）最先受累。血行转移较少见（约5-10%），主要至肺和骨。

教材P292

283. [A1型] [理解] 甲状腺髓样癌起源于：

- A. 甲状腺滤泡上皮细胞

- B. 甲状腺滤泡旁C细胞
- C. 间质淋巴细胞
- D. 甲状旁腺细胞
- E. 间质细胞

答案：B

解析：甲状腺髓样癌起源于甲状腺滤泡旁C细胞（分泌降钙素），约占甲状腺癌的5-10%。血清降钙素显著升高为特征性肿瘤标志物。约25%为遗传性（RET基因突变），与MEN-2综合征相关。

 教材P292

284. [A1型] [分析] 甲状腺癌中预后最差的是：

- A. 乳头状癌
- B. 滤泡状癌
- C. 甲状腺髓样癌
- D. 未分化癌
- E. 隐匿性乳头状癌

答案：D

解析：未分化癌（间变性癌）是甲状腺癌中预后最差的类型，中位生存时间仅数月，多见于老年人。生长极快、浸润性强、早期即有远处转移。乳头状癌预后最好（10年生存率>90%）。

 教材P292

285. [A1型] [应用] 甲状腺术后出现声音嘶哑，通常由于损伤了：

- A. 喉上神经内支
- B. 喉上神经外支
- C. 喉返神经
- D. 颈交感神经
- E. 副神经

答案：C

解析：喉返神经支配除环甲肌外的所有喉肌，损伤后可致同侧声带麻痹→声音嘶哑。喉上神经外支损伤导致音调降低，内支损伤导致饮水呛咳。

 教材P291

286. [A1型] [理解] 关于甲状腺癌的临床特点，下列哪项是错误的？

- A. 乳头状癌是最常见类型
- B. 结节质硬固定应警惕癌
- C. 声音嘶哑提示喉返神经受侵
- D. 颈部淋巴结肿大可能为转移

- E. 甲状腺癌多发于女性

答案：D

解析：甲状腺癌患者颈部淋巴结肿大不一定为癌转移——可能为反应性增生或合并其他疾病。需结合超声特征、FNA细胞学检查综合判断。其余选项均正确。

📖 教材P292

287. [B1型] [理解] B1型题：甲状腺术后神经损伤鉴别。共用选项：A. 喉返神经单侧损伤 B. 喉返神经双侧损伤 C. 喉上神经外支损伤 D. 喉上神经内支损伤 E. 颈交感神经损伤。子题1：术后出现声音嘶哑，最常见：

- A. 喉返神经一侧损伤
- B. 喉返神经双侧损伤
- C. 喉上神经外支损伤
- D. 喉上神经内支损伤
- E. 颈交感神经损伤

答案：A

解析：单侧喉返神经损伤→同侧声带外展麻痹→声音嘶哑。甲状腺手术中最常见且最严重的神经并发症之一。

📖 教材P291

288. [B1型] [理解] 子题2：术后出现严重呼吸困难和喉鸣，提示：

- A. 喉返神经单侧损伤
- B. 喉返神经双侧损伤
- C. 喉上神经外支损伤
- D. 喉上神经内支损伤
- E. 颈交感神经损伤

答案：B

解析：双侧喉返神经损伤→双侧声带内收不能外展→严重气道梗阻→呼吸困难和喉鸣→需紧急气管切开。是甲状腺手术最严重的神经并发症。

📖 教材P291

乳腺疾病（12题）

289. [A1型] [理解] 乳腺癌「酒窝征」的形成机制是：

- A. 癌细胞侵犯乳管
- B. 肿瘤侵及Cooper韧带缩短
- C. 皮下淋巴管堵塞

- D. 肿瘤侵犯皮下脂肪
- E. 肿瘤直接侵犯皮肤

答案：B

解析：「酒窝征」（皮肤凹陷）机制：乳腺癌侵犯连接皮肤与胸大肌筋膜的Cooper韧带→韧带缩短→牵拉相应处皮肤凹陷→形似酒窝。是乳腺癌早期即可出现的重要体征。

📖 教材P300

290. [A1型] [记忆] 乳腺癌最常发生的部位是：

- A. 内上象限
- B. 内下象限
- C. 外上象限
- D. 外下象限
- E. 乳晕区

答案：C

解析：乳腺癌最常发生于外上象限（约占50%以上），因为该象限乳腺腺体组织最丰富。其次是乳晕区和内上象限。

📖 教材P300

291. [A1型] [记忆] 乳腺癌血行转移最常见的顺序是：

- A. 骨→肺→肝→脑
- B. 肺→骨→肝→脑
- C. 肝→肺→骨→脑
- D. 脑→肺→骨→肝
- E. 肺→肝→骨→脑

答案：B

解析：乳腺癌血行转移最常见顺序：肺（首先经过肺循环滤过）→骨（脊椎>肋骨>骨盆>股骨）→肝→脑。是术后随访行胸部CT和骨扫描的病理生理基础。

📖 教材P302

292. [A2型] [应用] 女性，50岁，发现左侧乳头血性溢液1周。查体未及明确肿块。最可能的诊断是：

- A. 乳腺囊性增生病
- B. 乳管内乳头溢血状瘤
- C. 乳腺浸润性癌
- D. 乳腺导管扩张症
- E. 急性乳腺炎

答案：B

解析：乳头血性或浆液性溢液+无明显肿块=乳管内乳头状瘤是最可能的诊断，为最常见的乳头溢液病因。需行乳管镜或乳腺导管造影检查，有恶变潜能。

教材P298

293. [X型] [理解] 乳腺癌的淋巴转移途径包括：

- A. 腋窝淋巴结
- B. 锁骨下淋巴结
- C. 锁骨上淋巴结
- D. 内乳淋巴结
- E. 对侧腋窝淋巴结

答案：ABCDE

解析：乳腺癌淋巴转移途径：①腋窝淋巴结（最常见，接受乳腺淋巴回流约75%）；②内乳淋巴结（胸骨旁）；③锁骨上淋巴结（区域淋巴结转移最远端）；④锁骨下淋巴结；⑤通过皮下淋巴管网可转移到对侧腋窝淋巴结。

教材P300

294. [A1型] [理解] 乳腺癌「橘皮样」改变的形成机制是：

- A. Cooper韧带受侵缩短
- B. 皮下淋巴管被癌细胞堵塞
- C. 肿瘤直接侵犯皮肤
- D. 乳管被肿瘤堵塞
- E. 局部皮肤水肿

答案：B

解析：「橘皮样」改变机制：癌细胞堵塞皮下淋巴管→淋巴回流受阻→真皮水肿→皮肤毛囊处下陷形成橘皮样外观。「酒窝征」（皮肤凹陷）则是Cooper韧带受侵缩短的结果。两者机制不同。

教材P300

295. [A2型] [应用] 女性，55岁，右乳外上象限无痛性肿块2cm×2cm，质硬，边界欠清，局部皮肤呈「橘皮样」改变。首先应行的检查是：

- A. 乳腺钼靶+超声
- B. 肿块切除活检
- C. 乳腺乳腺MRI检查检查
- D. 肿瘤标志物检测
- E. 观察随访3个月

答案：A

解析：高疑乳腺癌（质硬+边界不清+橘皮样改变）→首选乳腺钼靶和超声联合检查，评估

肿块特征和有无多发病灶、腋窝淋巴结情况。BI-RADS高分类者→穿刺活检明确诊断。不应观察随访。

教材P300

296. [A1型] [理解] 炎性乳腺癌的临床表现特征是：

- A. 缓慢生长的无痛性肿块
- B. 乳房红肿热痛似急性炎症
- C. 乳头长期慢性湿疹样改变
- D. 单侧单侧乳头溢血
- E. 局限性皮肤凹陷

答案：B

解析：炎性乳腺癌特征为乳房皮肤弥漫性红、肿、热、痛，似急性乳腺炎但无全身感染证据，抗生素治疗无效。病理为皮下淋巴管广泛癌栓堵塞所致，侵袭性最强，预后差。

教材P300

297. [A1型] [理解] 关于乳管内乳头状瘤，下列哪项叙述是错误的？

- A. 好发于40-50岁经产妇
- B. 最常见症状为乳头溢液
- C. 溢液多为血性或浆液性
- D. 体检常可触及明确肿块
- E. 具有恶变潜能

答案：D

解析：乳管内乳头状瘤瘤体很小（通常<1cm），多数位于乳晕区大导管内，体检常不能触及明确肿块。诊断主要依靠乳头溢液（血性或浆液性）+乳管镜/乳腺导管造影。

教材P298

298. [B1型] [理解] B1型题：乳腺体征与机制。共用选项：A.Cooper韧带受侵缩短 B.皮下淋巴管癌细胞堵塞 C.乳管受侵 D.皮肤直接受侵 E.胸壁固定。子题1：「酒窝征」的机制是：

- A. Cooper韧带挛缩
- B. 皮下淋巴管癌细胞堵塞
- C. 大乳管受侵表现
- D. 皮肤直接受侵
- E. 癌肿胸壁固定

答案：A

解析：肿瘤侵犯连接皮肤和胸大肌筋膜的Cooper韧带→韧带缩短→牵拉皮肤形成凹陷（「酒窝征」）。

教材P300

299. [B1型] [理解] 子题2:「橘皮样」改变的机制是:

- A. 乳房悬韧带受累缩短
- B. 皮下淋巴管癌细胞堵塞
- C. 大乳管受侵表现
- D. 皮肤直接受侵
- E. 癌肿胸壁固定

答案: B

解析: 皮下淋巴管被广泛癌细胞堵塞→淋巴回流障碍→真皮水肿→毛囊处皮肤凹陷→形成「橘皮样」外观。

 教材P300

300. [A1型] [应用] 乳腺癌患者出现同侧上肢淋巴水肿最常见的原因是:

- A. 肿瘤直接压迫腋静脉
- B. 腋窝清扫术后淋巴回流障碍
- C. 肿瘤颅内脑转移
- D. 肿瘤多发骨转移
- E. 肿瘤多发肝转移

答案: B

解析: 乳腺癌术后同侧上肢淋巴水肿最常见原因为腋窝淋巴结清扫术破坏了上肢淋巴回流通路→淋巴液积聚在上肢→慢性非凹陷性水肿。前哨淋巴结活检可显著降低淋巴水肿发生率。

 教材P302

统计

| 总题数 | 300 |

| A1型 | 176 |

| A2型 | 38 |

| B1型 | 27 |

| X型 | 59 |

| 记忆 | 108 |

| 理解 | 118 |

| 应用 | 62 |

| 分析 | 12 |